HOLOHACKING



Jornada da Nutricionista com a Paciente

Do primeiro contato ao acompanhamento longitudinal em Nutrição Holística

Um guia de utilização do HoloHacking ao longo de um ciclo de acompanhamento de até 10 atendimentos

PRIMEIRO MODELO · OUTUBRO DE 2026 · DOCUMENTO EM CONSTRUÇÃO

APRESENTAÇÃO

Para quem é este documento

Este guia é para a nutricionista que acompanha pacientes com o HoloHacking. Ele não é um manual de botões. Ele mostra **como conduzir um acompanhamento de Nutrição Holística usando o HoloHacking**: o que acontece antes da primeira consulta, o que fazer em cada encontro, como o sistema ajuda a organizar a jornada e onde a decisão é sempre da profissional.

Ao longo do texto, cada etapa responde a quatro perguntas: o que a nutricionista faz, o que a paciente faz, o que o sistema faz e o que aquela etapa produz.

O sistema organiza. O método orienta. A tecnologia sugere.
A nutricionista interpreta. A nutricionista decide.

A LÓGICA DE TODO O HOLOHACKING

Como ler este documento

Os capítulos seguem a ordem natural de um acompanhamento. As caixas abaixo aparecem em todo o texto e ajudam a separar o que é do sistema, o que é da profissional e o que é da paciente.

NA PRÁTICA
Como a etapa acontece no dia a dia do consultório.

O QUE O SISTEMA FAZ
O que o HoloHacking registra, calcula ou organiza sozinho.

O QUE A NUTRICIONISTA DECIDE
O que só a nutricionista pode decidir.

O QUE A PACIENTE PERCEBE
O que a paciente vive, entende ou recebe.

◆ ATENÇÃO METODOLÓGICA
Um limite do método que não pode ser esquecido.

RESULTADO DESTA ETAPA
O que a etapa deixa registrado.

PRÓXIMO PASSO

Para onde a jornada segue.

✧ VISÃO FUTURA / EXPERIÊNCIA DESEJADA

Algo que **ainda não existe** no produto. Está descrito como experiência desejada, não como função atual.

◆ ATENÇÃO METODOLÓGICA

Este é o primeiro modelo do documento. Ele foi escrito a partir de uma auditoria do sistema real (outubro de 2026, pacote metodológico HOLOS-V1 v6). Ele será refinado, condensado e revisado. Todas as pessoas e dados citados são **fictícios**.

Sumário

01 O que é o HoloHacking

02 A jornada em uma página

03 Antes da primeira consulta

04 Mapeamento Holístico

05 A primeira consulta

06 HOLOSCAN

07 Do HOLOSCAN às ferramentas

08 Ferramentas de Corpo, Mente e Espírito

09 Leitura profissional e Conduta

10 Resultado HOLOS

11 O que a nutricionista vê

12 O que a paciente recebe

13 Resultado Final, PDF e WhatsApp

14 Retornos: o princípio fundamental

15 Mapa de um ciclo de até 10 atendimentos

16 Os 10 atendimentos, um a um

17 Resultados esperados de um ciclo

18 Caso fictício: Marina

19 Visão resumida dos 10 atendimentos

20 Corpo, Mente e Espírito ao longo da jornada

21 Acompanhamento longitudinal

22 Papéis

23 Limites e segurança

24 Visão futura

25 Encerramento

O que é o HoloHacking

Um ambiente profissional para a Nutrição Holística: reúne as informações do acompanhamento e transforma dados dispersos numa jornada organizada.

Num acompanhamento de nutrição, as informações chegam de muitos lugares: a conversa, o que a paciente conta antes da consulta, questionários, exercícios de reflexão, acordos, retornos. Sem um lugar para reuni-las, elas se perdem entre anotações, mensagens e memória.

O HoloHacking é esse lugar. Ele guarda a ficha da paciente, os atendimentos, o Mapeamento Holístico, o HOLOSCAN, as ferramentas de Corpo, Mente e Espírito, o Resultado HOLOS, a Conduta, os documentos e o histórico. E faz isso **sem decidir pela nutricionista**.

Organiza	Orienta	Sugere	Interpreta	Decide
o sistema	o método	a tecnologia	a nutricionista	a nutricionista

O que o HoloHacking é

- Um **prontuário organizado** da jornada: cada atendimento, cada registro e cada decisão ficam ligados à paciente e à data em que aconteceram.
- Um **método aplicado**: o HOLOSCAN e as ferramentas seguem um pacote metodológico versionado, com regras fixas e iguais para todas as pacientes.
- Um **apoio à leitura profissional**: o sistema mostra onde aprofundar e quais ferramentas o catálogo sugere, sempre como sugestão.
- Um **canal de entrega**: o que a nutricionista escolhe compartilhar vira um Resultado para a paciente, em PDF.

O que o HoloHacking não é

- Não é um sistema de diagnóstico.
- Não é inteligência artificial que decide tratamento. O HOLOSCAN segue uma regra fixa do método: o resultado depende só das respostas da paciente. Se ela responde diferente, o resultado muda; se as respostas forem exatamente as mesmas, a conta chega sempre ao mesmo resultado, sem sorteio e sem "opinião" do sistema.
- Não substitui a conversa clínica, a avaliação profissional nem o julgamento da nutricionista.
- Não prescreve dieta nem conduta automaticamente.

> *O HoloHacking não decide pela nutricionista. Ele deixa a decisão dela mais informada e mais bem registrada.*

Os três territórios: Corpo, Mente e Espírito

O método olha a paciente em três territórios. Eles organizam as ferramentas e a Tríade do HOLOSCAN, mas **não são trilhos separados** nem uma sequência obrigatória.

TERRITÓRIO	O QUE OBSERVA	FERRAMENTAS
Corpo	rotina, hábitos, sinais percebidos, capacidade prática de mudar	OQ³ · Linha do Momentum · Mapa da Rotina
Mente	motivos, crenças, padrões de comportamento e emoção	PQQ (Escada dos Porquês) · Mapa de Crenças Alimentares · Gatilhos & Respostas
Espírito	sentido, valores, direção, apoio e pertencimento	Mapa do Propósito · Roda Holística da Vida · Carta ao Futuro Eu · Conexão & Pertencimento

A jornada em uma página

Do primeiro contato ao novo ciclo: a sequência natural de um acompanhamento no HoloHacking.

1 AGENDAMENTO / ENTRADA
A paciente marca a consulta. A nutricionista registra na Agenda.

2 CADASTRO
A ficha da paciente é criada. Só o nome é obrigatório.

3 MAPEAMENTO HOLÍSTICO
A paciente responde pelo celular, sem criar conta.

4 REVISÃO PRÉ-CONSULTA
A nutricionista lê as respostas antes de encontrar a paciente.

5 PRIMEIRO ATENDIMENTO
A consulta é aberta no sistema e a conversa começa.

6 HOLOSCAN
O questionário organiza os relatos em cinco sistemas.

7 ÁREAS PARA APROFUNDAR
O resultado mostra por onde a investigação pode começar.

8 FERRAMENTAS
O catálogo sugere; a nutricionista escolhe se e quando aplicar.

9 LEITURA PROFISSIONAL
A nutricionista registra o que entendeu.

10 CONDUTA
Objetivo, estratégia, ações e acordos da etapa.

11 RESULTADO PARA A PACIENTE
O que foi entendido e combinado, em linguagem humana.

12 ACOMPANHAMENTO
A paciente experimenta os acordos no dia a dia.

13 RETORNOS
Cada encontro revisa, aprofunda ou ajusta.

14 EVOLUÇÃO
O histórico mostra o caminho percorrido, lado a lado.

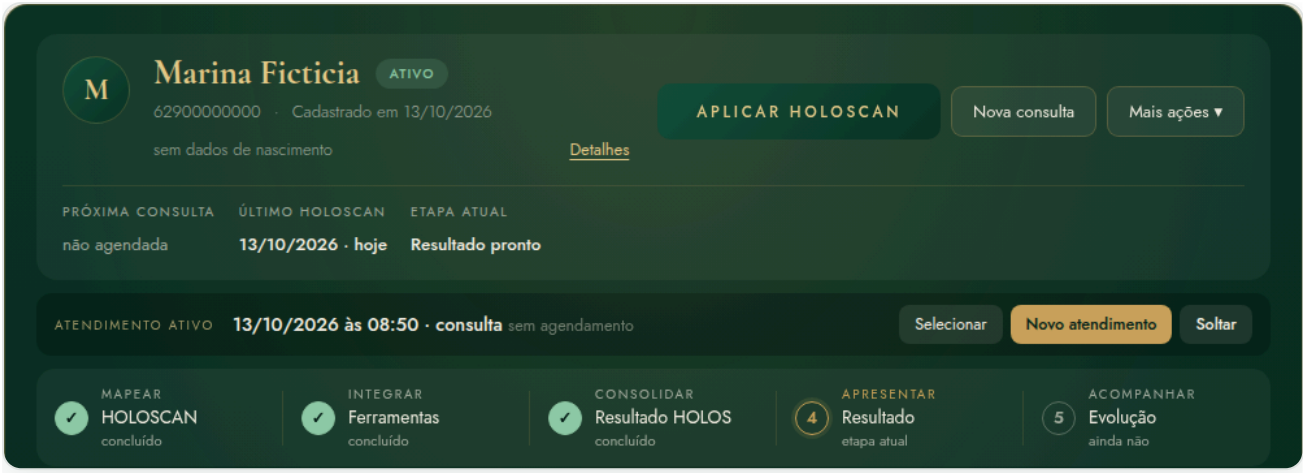
15 NOVO CICLO OU CONCLUSÃO
A nutricionista decide como seguir.

◆ ATENÇÃO METODOLÓGICA

A sequência é a ordem mais comum, não uma regra. Uma paciente pode chegar sem Mapeamento, uma consulta pode não ter HOLOSCAN, uma ferramenta pode esperar. **A nutricionista conduz; o sistema acompanha.**

Cada etapa em poucas palavras

ETAPA	O QUE ACONTECE	ONDE FICA NO HOLOHACKING
Agendamento	A consulta é marcada com tipo (Primeira consulta, Retorno, Reavaliação HOLOSCAN, Online) e duração.	Agenda
Cadastro	Nome (obrigatório), nascimento, telefone, e-mail, sexo, início do acompanhamento, queixa principal.	Pacientes → Cadastrar paciente
Mapeamento Holístico	Link individual, válido por 7 dias, enviado pelo WhatsApp.	Ficha → Mapeamento Holístico
Revisão pré-consulta	Leitura das respostas da paciente, que chegam à ficha.	Ficha → Mapeamento Holístico
Primeiro atendimento	"Iniciar atendimento" (na Agenda) ou "Novo atendimento" (na ficha).	Ficha → Atendimento ativo
HOLOSCAN	Questionário respondido na consulta; o sistema calcula e salva.	HOLOSCAN
Áreas para aprofundar	"Por onde investigar": os dois sistemas de nota mais baixa.	Resultado do HOLOSCAN
Ferramentas	"Próximos Passos HOLOS": uma ferramenta principal e até duas complementares.	Corpo, Mente, Espírito
Leitura profissional	Interpretação do HOLOSCAN, leitura de cada ferramenta, observações do Resultado.	HOLOSCAN, ferramentas, Resultado HOLOS
Conduta	Objetivo, estratégia, ações, recursos, orientações, retorno e acordos.	Ficha → Conduta
Resultado para a paciente	Resultado HOLOS (visão da paciente) e Resultado Final emitido, em PDF.	Resultado HOLOS e Resultado
Retornos e evolução	Novo atendimento, Mapeamento de retorno, revisão de acordos, comparação lado a lado.	Ficha → Atendimentos, Conduta, Evolução



O QUE A NUTRICIONISTA VÊ A ficha da paciente fictícia Marina: botão "Aplicar HOLOSCAN", próxima consulta, último HOLOSCAN, etapa atual, atendimento ativo e a faixa da jornada clínica (Mapear, Integrar, Consolidar, Apresentar, Acompanhar), marcada só a partir de dados reais.

Antes da primeira consulta

A preparação começa antes de a paciente entrar no consultório. Bem feita, ela devolve tempo à conversa.

Passo a passo

1. **A paciente agenda.** A nutricionista registra a consulta na Agenda, com o tipo "Primeira consulta".
2. **A nutricionista cadastra a paciente.** Só o nome é obrigatório; o resto pode ser completado depois. O telefone é o que permite enviar o Mapeamento pelo WhatsApp.
3. **O sistema cria a ficha.** Ela já nasce com a faixa da jornada vazia, pronta para ser preenchida pelos registros reais.
4. **A nutricionista gera o Mapeamento Holístico.** Na aba "Mapeamento Holístico", o botão "Enviar Mapeamento Holístico" cria um link individual, válido por 7 dias.
5. **Envia o link pelo WhatsApp.** O botão "Enviar pelo WhatsApp" abre a conversa com a paciente já com a mensagem pronta. Também é possível copiar o link.
6. **A paciente abre o link no celular, sem criar conta e sem senha.**
7. **A paciente responde.** As respostas são salvas sozinhas; ela pode parar e continuar depois pelo mesmo link.
8. **A paciente envia.** Depois de enviado, o Mapeamento não pode mais ser alterado pelo link.
9. **As respostas chegam ao HoloHacking.** O cartão muda para "Concluído" e mostra "Mapeamento recebido".
10. **A nutricionista revisa antes da consulta.** Ela lê as respostas, organizadas por etapa.
11. **Na consulta, leva as informações para o atendimento.** Com o atendimento aberto, o botão "Levar para o atendimento" transforma as respostas num rascunho do Mapeamento profissional daquele atendimento.

O QUE A NUTRICIONISTA DECIDE

- Quando enviar o Mapeamento (e se vale enviar).
- O que perguntar a partir das respostas.
- O que levar para o atendimento e o que corrigir no rascunho.

O QUE A PACIENTE PERCEBE

- Recebe uma mensagem pessoal da nutricionista.
- Responde no próprio tempo, pelo celular, em poucos minutos.
- Chega à consulta já tendo pensado sobre o que a trouxe.

O QUE O SISTEMA FAZ

- Gera um link individual e seguro, com validade de 7 dias.
- Salva as respostas automaticamente enquanto a paciente preenche.
- Mostra o estado do convite: Não enviado, Enviado, Iniciado, Concluído, Expirado ou Revogado.

RESULTADO DESTA ETAPA

Um retrato inicial, **relatado pela própria paciente**, pronto para orientar a primeira conversa. Não é diagnóstico nem conclusão.



O QUE ACONTECE NESTA ETAPA O link é gerado com validade de 7 dias. Ele aparece só neste momento; para reenviar, gera-se um link novo, que substitui o anterior.

NA PRÁTICA

A mensagem que o sistema prepara para o WhatsApp diz: *"Olá, [primeiro nome]. Antes da nossa consulta, peço que preencha o seu Mapeamento Holístico da Saúde pelo link abaixo: [link]. As informações serão utilizadas para preparar seu atendimento."* A nutricionista pode ajustar o texto antes de enviar.

Mapeamento Holístico

Um formulário curto que a paciente responde antes da consulta. Ele prepara o atendimento e organiza o que ela relata. Não é diagnóstico nem ferramenta terapêutica.

Finalidade

O Mapeamento Holístico da Saúde reúne, antes do primeiro encontro, o que a paciente busca, como come, o que percebe no corpo, como está a sua saúde, a sua rotina e o seu momento de vida. Com isso, a nutricionista chega à consulta sabendo por onde começar e usa o tempo do encontro para escutar e aprofundar, não para preencher formulário.

Diferença entre Mapeamento e HOLOSCAN

	MAPEAMENTO HOLÍSTICO	HOLOSCAN
Quando	Antes da consulta (e nos retornos)	Dentro do atendimento
Quem responde	A paciente, sozinha, pelo celular	A paciente, com a nutricionista
Para quê	Preparar a consulta e registrar o contexto	Organizar relatos em cinco sistemas, segundo o método
Gera nota?	Não	Sim: notas por sistema, Índice HOLOS e Tríade
Sugere ferramenta?	Não	Sim, pelo catálogo (PP-V1)

Como é o formulário da paciente

O formulário de primeira consulta foi pensado para levar poucos minutos e é quase todo de toque, com perguntas de escolha. Nada é obrigatório, e a paciente pode responder "Prefiro não responder" nas questões sensíveis. **Peso e medidas não são pedidos à paciente.**

1 · 1 · O QUE TE TRAZ AQUI
Motivo do acompanhamento, o que mais gostaria de melhorar, experiências anteriores com nutrição.

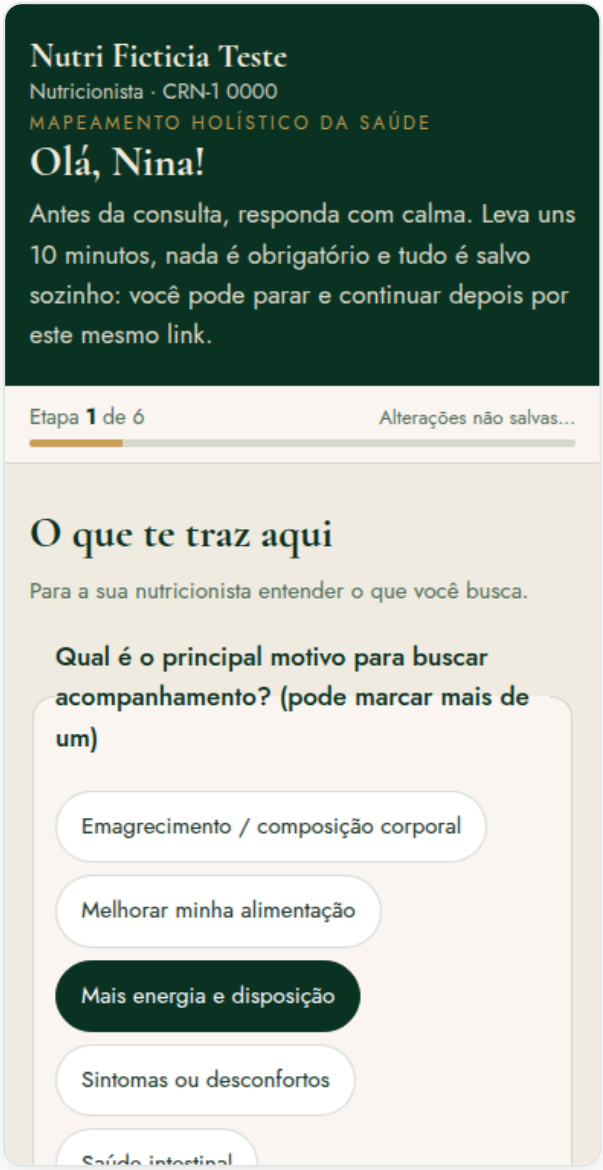
2 · 2 · ALIMENTAÇÃO E SINAIS
Padrão alimentar, até três dificuldades, fome, sinais percebidos no corpo, o que mais incomoda, água.

3 · 3 · SAÚDE E CUIDADOS
Condições já informadas por profissionais, cirurgias, medicamentos, suplementos, alergias, intolerâncias.

4 · SONO, HÁBITOS E ROTINA
Horários de sono, previsibilidade da rotina, trabalho, atividade física, álcool, tabaco, o que dificulta e o que ajuda.

5 · SEU MOMENTO ATUAL
Opcional: mudanças recentes, apoio, algo pessoal que queira contar.

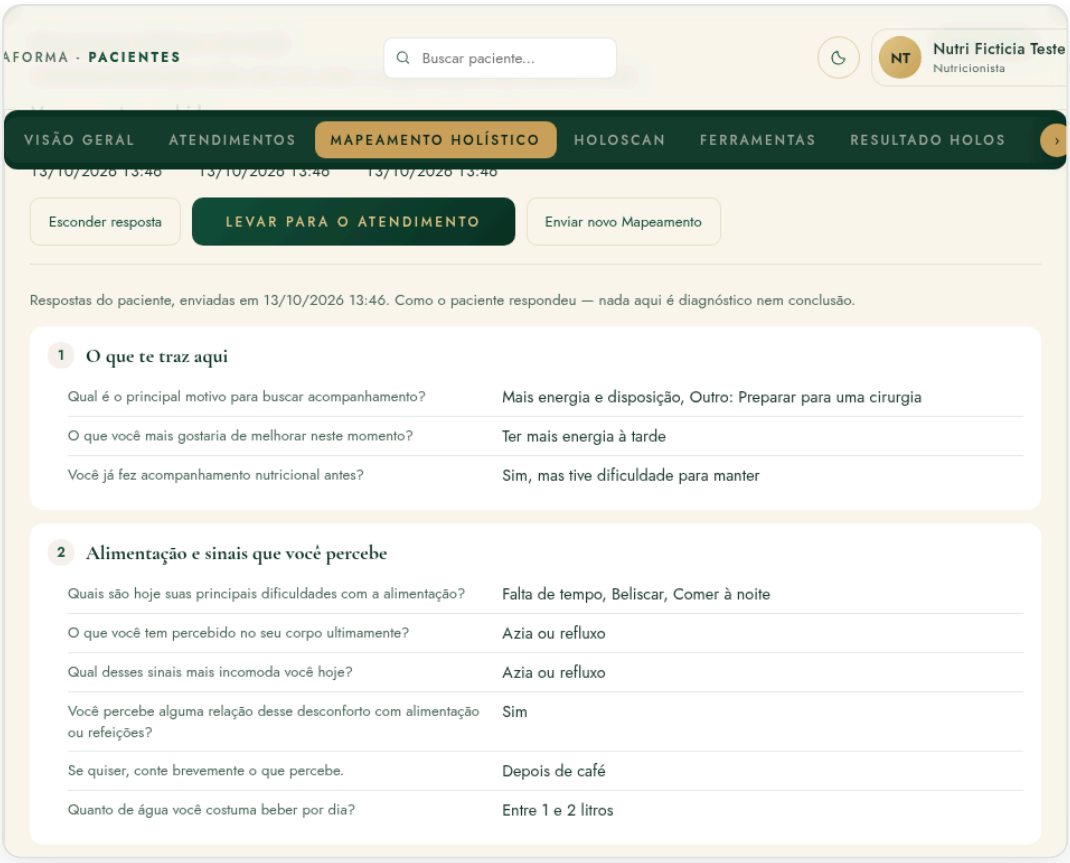
6 · REVISAR E ENVIAR
Resumo das respostas e um espaço livre final.



O QUE A PACIENTE VÊ A primeira etapa do Mapeamento no celular (paciente fictícia). As respostas são salvas sozinhas e a paciente pode continuar depois pelo mesmo link.

Como as respostas chegam

Quando a paciente envia, a aba "Mapeamento Holístico" da ficha mostra o cartão "Concluído" e as respostas organizadas por etapa, com a data do envio. O sistema avisa: *"Como o paciente respondeu — nada aqui é diagnóstico nem conclusão."* Os botões são "Ver resposta" / "Esconder resposta", "Levar para o atendimento" e "Enviar novo Mapeamento". Mapeamentos anteriores ficam guardados em "Mapeamentos anteriores".



O QUE A NUTRICIONISTA VÊ As respostas recebidas na ficha, antes da consulta (paciente fictícia).

"Levar para o atendimento"

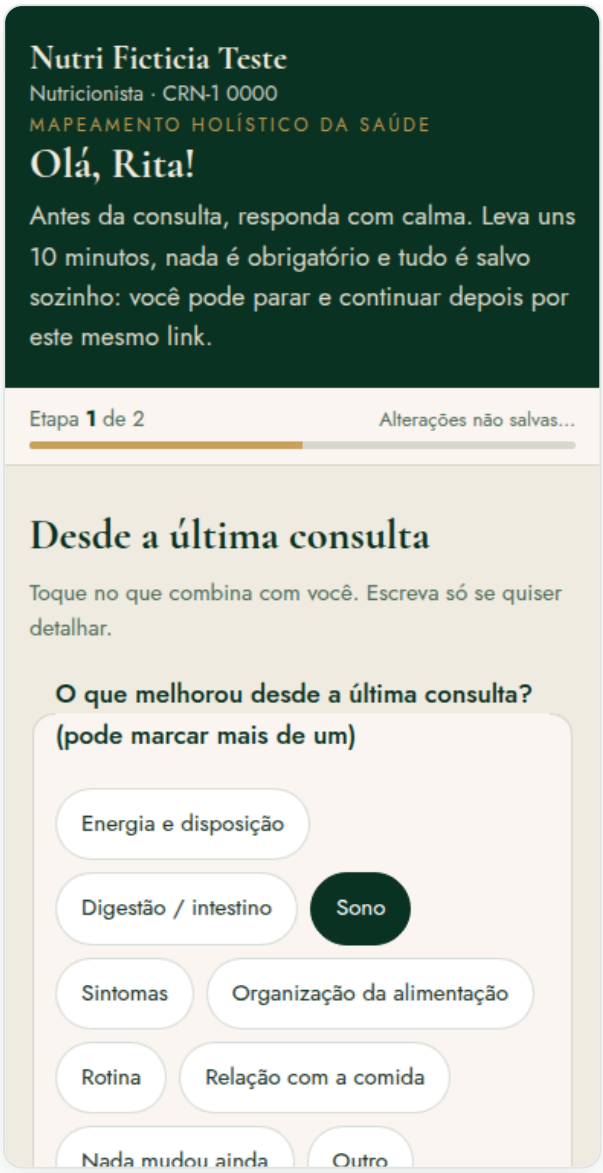
Na consulta, com o atendimento aberto, "Levar para o atendimento" transforma as respostas da paciente num **rascunho** do Mapeamento profissional daquele atendimento, marcado como "relato da paciente". A nutricionista revisa, completa com o que ouviu na conversa e conclui. A resposta original da paciente não é alterada.

O QUE O SISTEMA FAZ

- Só funciona com um atendimento ativo, e só se aquele atendimento ainda não tiver Mapeamento.
- O Mapeamento profissional tem salvamento automático enquanto é escrito e, depois de concluído, não é editado: uma correção vira uma **nova revisão**.
- O Mapeamento profissional tem blocos para motivo e objetivo, história e rotina alimentar, saúde e sintomas, medicamentos e restrições, estilo de vida, histórico e contexto, e avaliação objetiva (preenchida pela nutricionista).

Mapeamento de retorno

Quando a paciente já tem um Mapeamento profissional concluído, o próximo link enviado é automaticamente o de **retorno**: uma etapa só, "Desde a última consulta" (o que melhorou ou piorou, o quanto conseguiu colocar em prática, o que ajudou e o que dificultou, mudanças, medicamentos, algo novo), mais a revisão.



O QUE A PACIENTE VÊ O Mapeamento de retorno, mais curto, enviado antes de um retorno (paciente fictícia).

O que o Mapeamento não faz

◆ **ATENÇÃO METODOLÓGICA**

- Não diagnostica nem conclui. Tudo o que está ali é **relato da paciente**.
- Não gera nota, não alimenta o HOLOSCAN e não escolhe ferramenta.
- Não é ferramenta terapêutica: ele prepara a conversa, não a substitui.

A primeira consulta

O encontro em que a jornada ganha um ponto de partida. A nutricionista escuta, organiza e combina o primeiro passo.

O fluxo do encontro

1. **Abrir o atendimento.** Pela Agenda ("Iniciar atendimento") ou pela ficha ("Novo atendimento"). Agendamento não é atendimento: o atendimento clínico só existe depois desse passo. Com ele ativo, o Mapeamento profissional, o HOLOSCAN e a Conduta ficam ligados àquele encontro.
2. **Revisar o contexto.** O Mapeamento recebido, a queixa principal e o que a paciente trouxe.
3. **Conversar.** O Mapeamento prepara a conversa; não a substitui.
4. **Levar o Mapeamento para o atendimento**, revisar e concluir o registro profissional.
5. **Aplicar o HOLOSCAN, quando pertinente.** A nutricionista decide se é o momento.
6. **Revisar o resultado do método.** Os cinco sistemas, o Índice, a Tríade e "Por onde investigar".
7. **Identificar as primeiras áreas para aprofundar**, à luz da conversa.
8. **Escolher uma ferramenta pertinente**, se fizer sentido, entre as sugeridas pelo catálogo.
9. **Aplicar a ferramenta** e registrar a leitura profissional.
10. **Construir a Conduta**: objetivo da etapa, estratégia, ações e acordos.
11. **Preparar o Resultado HOLOS** e escolher o que compartilhar com a paciente.
12. **Emitir o Resultado Final**, quando for o momento, e enviar o PDF.

◆ ATENÇÃO METODOLÓGICA

O HOLOSCAN não substitui a conversa clínica. Ele organiza relatos segundo o método; a escuta, o contexto e o julgamento profissional continuam sendo o centro da consulta.

O QUE A NUTRICIONISTA DECIDE

- Se aplica o HOLOSCAN nesta consulta.
- Se concorda com a ordem das áreas ou se a conversa pede outra prioridade.
- Se aplica uma ferramenta agora, depois ou não aplica.
- O que entra na Conduta e o que é compartilhado com a paciente.

RESULTADO DESTA ETAPA

- Um atendimento registrado, com data e hora.
- O Mapeamento profissional, um HOLOSCAN salvo e, se houver, uma ferramenta concluída.
- Uma Conduta com acordos.
- Um Resultado HOLOS e, quando emitido, um Resultado Final em PDF.

NA PRÁTICA

Nem tudo precisa acontecer no primeiro encontro. Em consultas curtas, é comum aplicar o HOLOSCAN e construir uma Conduta simples, deixando a primeira ferramenta para o retorno. O sistema não exige ordem nem completude.

HOLOSCAN

O HOLOSCAN é o questionário estruturado do método. Ele organiza o que a paciente relata em cinco sistemas e ajuda a decidir por onde começar a conversa. Ele não é diagnóstico, não é exame e não é inteligência artificial: é uma regra fixa do método. O resultado depende só das respostas; respostas iguais levam sempre ao mesmo cálculo, e respostas diferentes mostram um momento diferente.

O que é, em uma frase

O HOLOSCAN organiza relatos. Não diagnostica.

PRINCÍPIO DO MÉTODO

O HOLOSCAN é aplicado dentro de um atendimento, com a paciente. As perguntas são curtas, sobre o que ela percebe no dia a dia, e cada resposta é escolhida numa escala de quatro pontos:

TIPO DE PERGUNTA	OPÇÕES DE RESPOSTA
Frequência	Nunca · Às vezes · Frequente · Sempre
Intensidade	Nada · Um pouco · Bastante · Muito

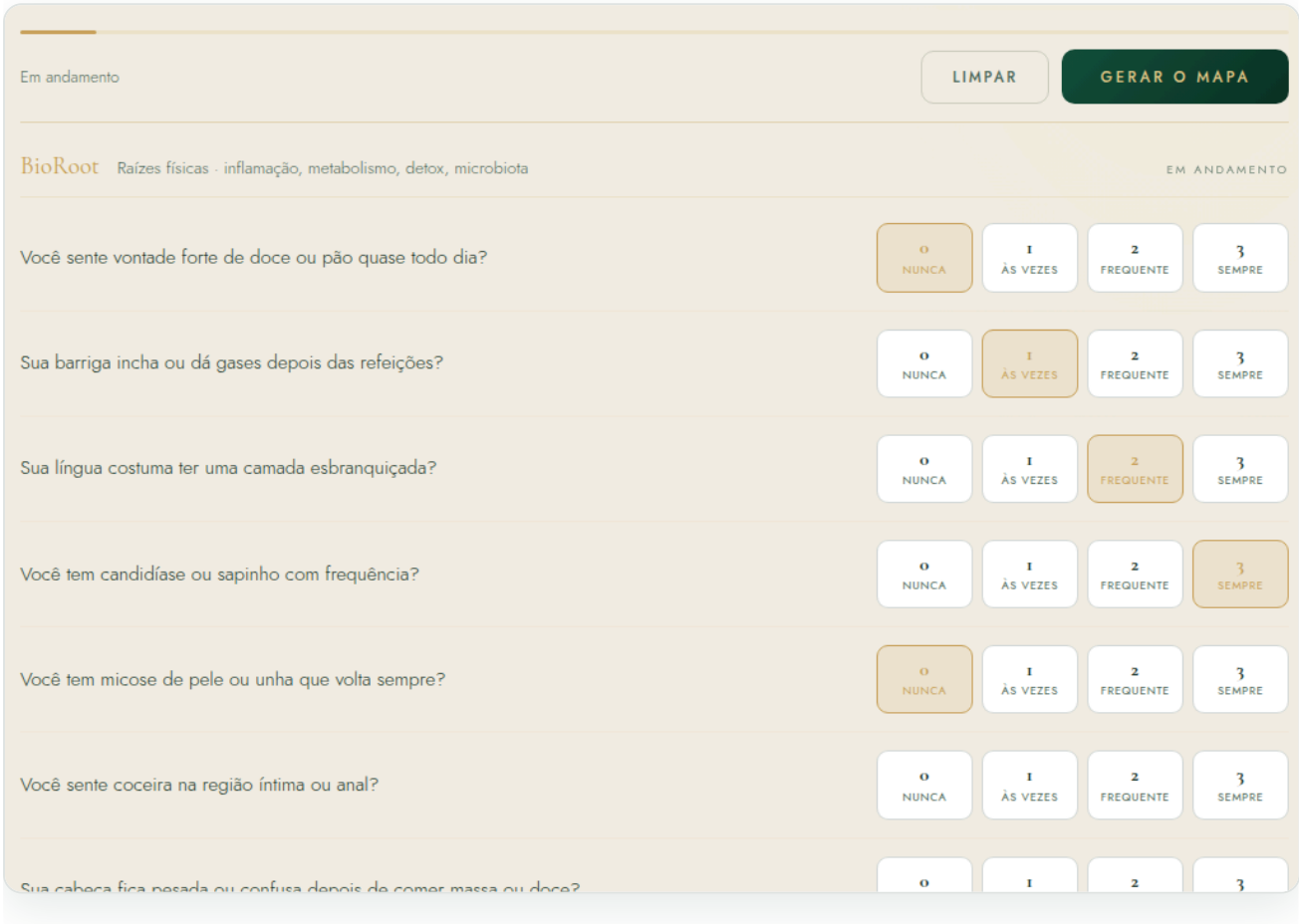
Na versão vigente do pacote metodológico (**HOLOS-V1 v6**, publicada em 13/10/2026), o questionário tem **81 perguntas**. Destas, **69 pontuam** em algum sistema e **12 são só de contexto**: ficam registradas para a nutricionista, mas não entram em nenhuma nota.

O QUE O SISTEMA FAZ

- Mostra as perguntas do pacote vigente, com o botão **Aplicar HOLOSCAN** (sem mostrar a quantidade de perguntas para a paciente).
- Calcula as notas dos cinco sistemas, o Índice HOLOS e a Tríade a partir das respostas, sempre com a mesma regra.
- Grava a aplicação junto com a versão do pacote usada, para que o histórico continue legível quando o método evoluir.

Como é aplicado

Na ficha, o botão "Aplicar HOLOSCAN" leva à seção HOLOSCAN, onde a paciente responde às perguntas, organizadas em três blocos: raízes físicas, padrões emocionais e propósito, valores e fé. Cada toque fica salvo no aparelho. Ao final, "Gerar o mapa" calcula o resultado e "Salvar HOLOSCAN" grava a aplicação no servidor, ligada ao atendimento ativo.



O QUE ACONTECE NESTA ETAPA O questionário em andamento. A paciente vê só as perguntas e a escala; a quantidade de perguntas não é mostrada.

NA PRÁTICA

Cada reaplicação começa do zero: nada é preenchido com respostas antigas. **Não existe intervalo automático para reaplicar.** A reaplicação é decisão profissional e contextual, até que uma regra oficial de periodicidade seja definida.

Os cinco sistemas

Os sistemas são **categorias autorais do método**. Cada um reúne um grupo de relatos. Nenhum deles mede órgão, função, substância ou doença.

Sistema Fúngico

Organiza relatos digestivos e alimentares (vontade de doce ou pão, inchaço e gases depois de comer, mal-estar com comida gordurosa, cabeça pesada depois de massa ou doce) e relatos de mucosas e couro cabeludo. **Não é detector de fungo**: não diagnostica candidíase, infecção fúngica nem disbiose. Pontuam 8 perguntas.

Sistema Ácido Inflamatório

Organiza relatos de dor, rigidez, desconforto e reatividade percebida: dor articular sem esforço, corpo travado ao acordar, azia, dor de cabeça frequente, gengiva que sangra, piora percebida com ultraprocessados. **Não mede inflamação nem pH**: "ácido" é nomenclatura do método. Pontuam 8 perguntas.

Sistema Metabólico

Organiza relatos de energia, fome, saciedade, comportamento alimentar e refeições: sono depois do almoço, fome pouco depois de comer, acordar cansada, perceber (ou não) fome e saciedade, começar a comer sem pausa. **Não diagnostica** resistência à insulina, diabetes, alterações da tireoide ou outras condições metabólicas. Exames não participam do HOLOSCAN. Pontuam 7 perguntas.

Sistema Detox e Linfático

Organiza relatos de retenção percebida, eliminação e sensibilidade a substâncias: pernas inchadas no fim do dia, rosto inchado ao acordar, intestino preso, reação forte a café, medicamento ou pouca bebida alcoólica, incômodo com cheiros. **Não mede toxinas**, função hepática nem fluxo linfático: "Detox" é nomenclatura do método. Pontuam 6 perguntas.

Sistema Mental Emocional Espiritual

Organiza relatos de pensamento, emoção, comportamento, autorregulação, identidade, conexão, valores e sentido: cabeça que não desliga, preocupação, comer para se acalmar, autocrítica, limites, mágoa, culpa depois de comer, direção e propósito. **Não diagnostica transtorno mental** e não mede saúde, valor ou qualidade espiritual. Pontuam 40 perguntas.

Nota, Índice HOLOS e Tríade

Nota do sistema (0 a 10)

É a posição do sistema dentro da escala do instrumento. Quanto **mais baixa**, mais carga a paciente relatou nas perguntas daquele sistema. Só existe nota quando pelo menos **80%** das perguntas do sistema foram respondidas.

Índice HOLOS (0 a 100)

É a média dos cinco sistemas, com o mesmo peso para cada um. Só é calculado quando os cinco sistemas têm nota. **Não é percentual de saúde.**

Tríade (Corpo · Mente · Espírito)

Agrupa as perguntas pelo bloco em que aparecem no questionário (36 de Corpo, 19 de Mente e 14 de Espírito). Ajuda a contextualizar; não escolhe ferramenta nem muda a prioridade.

◆ ATENÇÃO METODOLÓGICA

Uma nota baixa **não significa doença, gravidade nem risco**. Uma nota alta **não significa** ausência de doença nem "sistema saudável". A nota é sempre sobre os relatos daquela aplicação, naquele momento.

Sinais que pontuaram e contexto que não pontua

Em cada sistema, o Resultado mostra **até três sinais** que mais contribuíram para a nota: as perguntas em que a paciente relatou mais carga. Eles ajudam a entender *por que* aquele sistema apareceu, sem afirmar causa.

Algumas perguntas são **só de contexto**. Elas aparecem para a nutricionista num bloco separado, **"Contexto, sem pontuar"**, e não alteram nota, Índice, Tríade, prioridade, sinais nem Próximos Passos. São, por exemplo:

- condições nomeadas pela própria paciente (candidíase, micose, acne, eczema, psoríase);
- histórico (uso de antibiótico ao longo da vida);
- observações corporais que poderiam sugerir diagnóstico (distribuição de gordura, pele escurecida, dificuldade de perder peso, pele opaca, odor do suor, celulite);
- contexto de vida (contato com a natureza, refeições sozinha e com pressa).

> *O que é contexto informa a conversa. Não vira motivo da nota.*

Áreas para aprofundar

Com as notas calculadas, o sistema ordena os cinco sistemas da **nota mais baixa para a mais alta**. Os dois primeiros são a **1ª e a 2ª área para aprofundar** (em caso de empate, vale a ordem oficial do método).

◆ ATENÇÃO METODOLÓGICA

Prioridade aqui é prioridade de investigação, não de gravidade ou de risco. Quando um sistema não teve nenhuma carga (nota 10,0), o Resultado avisa que ele só aparece na lista pela ordem de desempate; a paciente não lê que essa área "aparece para aprofundar".



O QUE A NUTRICIONISTA VÊ "Resultado desta aplicação" (paciente fictícia Marina): os cinco sistemas do mais baixo ao mais alto, a Tríade e "Por onde investigar". A visão é profissional; a paciente recebe outra, em linguagem simples.

O QUE A NUTRICIONISTA DECIDE

A nutricionista lê as áreas **junto com a conversa e o Mapeamento**. Ela pode concordar com a ordem, aprofundar primeiro outra área que a conversa mostrou ser mais importante, ou esperar para decidir. O HOLOSCAN não substitui a conversa clínica.

Do HOLOSCAN às ferramentas

Como o resultado leva às ferramentas: pelo sistema, pelo catálogo, e sempre com a decisão da nutricionista no meio.

A lógica: sistema → catálogo → ferramenta

Os Próximos Passos HOLOS (catálogo **PP-V1**, com 30 regras aprovadas) funcionam assim:

ÁREAS PARA APROFUNDAR → SISTEMA → CATÁLOGO PP-V1 → FERRAMENTA SUGERIDA → DECISÃO DA NUTRICIONISTA

1. O HOLOSCAN mostra a 1ª e a 2ª área para aprofundar.
2. Para cada sistema, o catálogo tem uma lista ordenada de ferramentas que ajudam a aprofundá-lo.
3. O sistema propõe **uma ferramenta principal** (do sistema da 1ª área) e **até duas complementares**, sem repetir ferramenta. As já realizadas naquele atendimento aparecem marcadas.
4. A nutricionista avalia e decide.

A ferramenta é sugerida pelo catálogo para aprofundar este sistema.

TEXTO QUE ACOMPANHA CADA SUGESTÃO NO SISTEMA

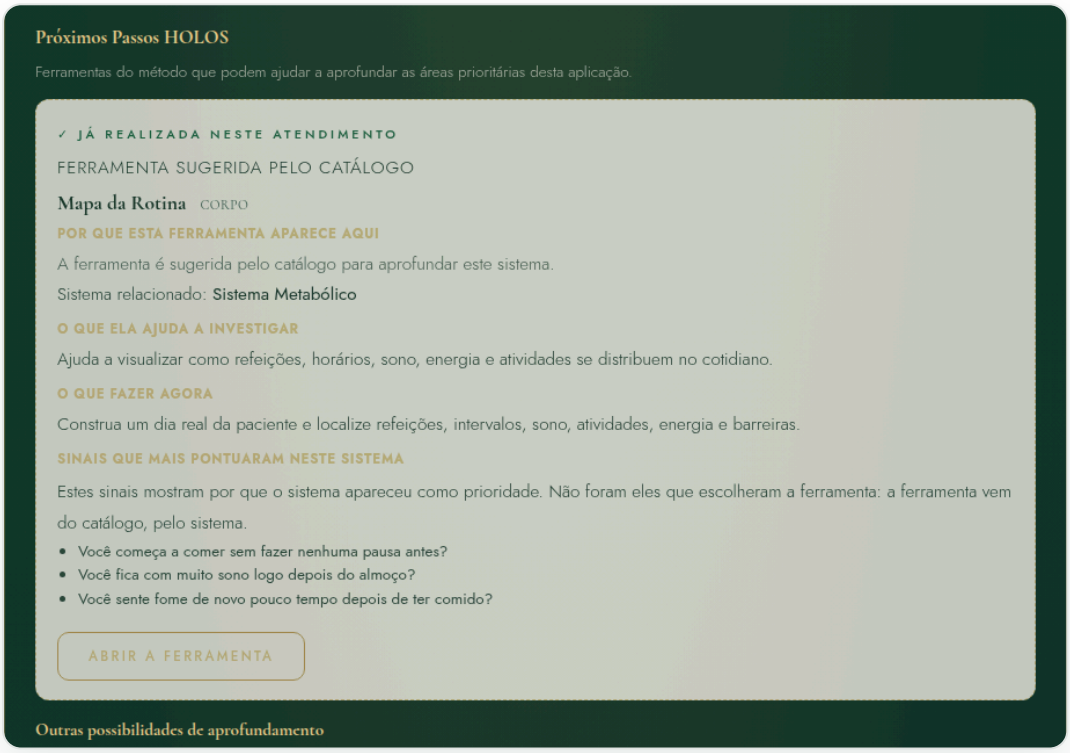
◆ ATENÇÃO METODOLÓGICA

Nenhuma pergunta isolada escolhe uma ferramenta. Os sinais que mais pontuaram mostram por que o sistema apareceu como prioridade; a ferramenta vem do catálogo, pelo sistema. Nenhuma ferramenta é obrigatória, e a ordem é uma recomendação, não uma sequência de atendimento.

O catálogo, sistema a sistema

SISTEMA	FERRAMENTAS DO CATÁLOGO, NA ORDEM DE SUGESTÃO
Fúngico	Mapa da Rotina · Gatilhos & Respostas · Mapa de Crenças Alimentares · Linha do Momentum · OQ³ · Conexão & Pertencimento

SISTEMA	FERRAMENTAS DO CATÁLOGO, NA ORDEM DE SUGESTÃO
Ácido Inflamatório	Mapa da Rotina · Linha do Momentum · Gatilhos & Respostas · Roda Holística da Vida · Conexão & Pertencimento · OQ³
Metabólico	Mapa da Rotina · Gatilhos & Respostas · Mapa de Crenças Alimentares · Linha do Momentum · OQ³ · Carta ao Futuro Eu
Detox e Linfático	Mapa da Rotina · Linha do Momentum · OQ³ · Roda Holística da Vida · Conexão & Pertencimento · Gatilhos & Respostas
Mental Emocional Espiritual	PQQ · Mapa de Crenças Alimentares · Gatilhos & Respostas · Mapa do Propósito · Carta ao Futuro Eu · Conexão & Pertencimento



O QUE A NUTRICIONISTA VÊ "Próximos Passos HOLOS": cada cartão diz a ferramenta sugerida pelo catálogo, por que ela aparece, o que ajuda a investigar e o que fazer agora. As ferramentas já realizadas no atendimento ficam marcadas (paciente fictícia).

O que a nutricionista considera antes de aplicar

O QUE A NUTRICIONISTA DECIDE

- **A sugestão do catálogo**, como ponto de partida.
- **A conversa**: o que a paciente trouxe pode pedir outra ferramenta ou outro território.
- **O momento da paciente**: energia, tempo e disponibilidade para refletir naquele dia.
- **O que já foi feito**: ferramentas aplicadas antes e o que elas mostraram.

E então decide: aplicar agora, aplicar no retorno ou não aplicar. Seguir, abrir outra ferramenta ou ignorar a sugestão **não altera o Resultado do HOLOSCAN**.

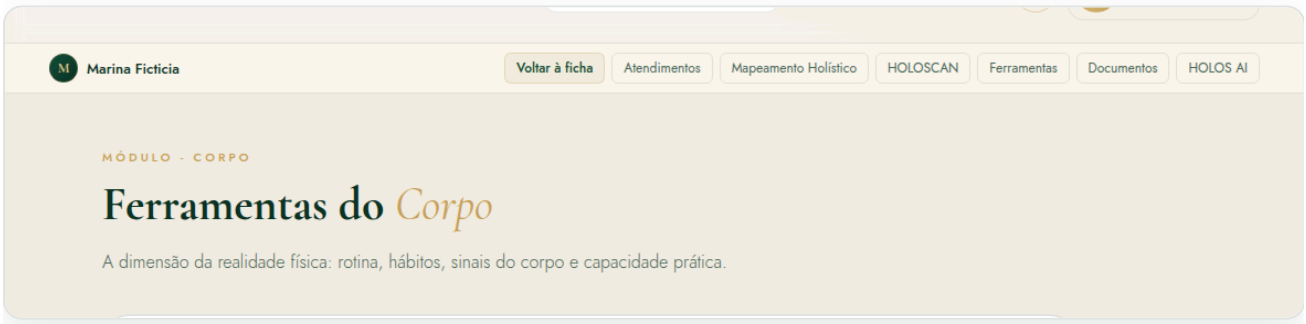
Ferramentas de Corpo, Mente e Espírito

Dez ferramentas para aprofundar o que o HOLOSCAN e a conversa mostraram. Nenhuma é diagnóstica, nenhuma é obrigatória e nenhuma transforma a nutrição em psicoterapia.

Como as ferramentas funcionam no HoloHacking

O QUE O SISTEMA FAZ

- Cada ferramenta tem um formulário próprio, nas seções **Corpo**, **Mente** e **Espírito** do menu, e aparece também na aba "Ferramentas" da ficha.
- Quando há um atendimento ativo, a aplicação fica ligada a ele.
- Toda ferramenta pode ser aplicada de novo ("Nova aplicação"); as anteriores continuam no histórico. Não há reaplicação automática.
- **Mapa da Rotina, Gatilhos & Respostas** e **Conexão & Pertencimento** são registros estruturados: depois de concluídos, não são editados (é possível criar "Nova a partir desta").
- Em sete ferramentas há a **leitura profissional**: "O que chamou atenção", "Prioridade" e "Próximo passo".
- O resultado de cada ferramenta mostra "O que apareceu" (descritivo, sem nota) e, quando existe texto aprovado, "O que isso pode mudar no acompanhamento".
- O que a paciente vê é escolhido no Resultado HOLOS, ferramenta por ferramenta ("Mostrar ao paciente").



O QUE A NUTRICIONISTA VÊ As ferramentas do Corpo, com o estado de cada uma para a paciente ativa: disponível, concluída ou revisada (paciente fictícia).

CORPO

Corpo: a realidade prática

OQ³ — O Que Quer, Precisa, Consegue

CORPO · 01

FINALIDADE	Clareza entre desejo, necessidade e capacidade prática da paciente neste momento.
QUANDO É ÚTIL	No início do acompanhamento, ou quando há muitos pontos possíveis de trabalho e é preciso escolher um foco realista.
COMO FUNCIONA	Três perguntas: o que a paciente quer conquistar (OQQ), o que ela precisa resolver (OQP) e do que ela consegue dar conta agora (OQCC), mais as "alavancas da transformação".
O QUE PRODUZ	Um registro das três dimensões lado a lado, com data.
COMO A NUTRICIONISTA USA	Para planejar a etapa considerando ao mesmo tempo desejo, necessidade e capacidade. Junto com o PQQ, libera o Mapa do Propósito como aprofundamento opcional.
NO PRÓXIMO ATENDIMENTO	Serve de referência para revisar se o foco combinado ainda cabe no que a paciente consegue sustentar.
O QUE NÃO SIGNIFICA	Não mede motivação nem compromisso. Não é meta clínica.
LIMITES	É um instrumento de planejamento da etapa; as decisões continuam sendo da nutricionista, com a paciente.

Linha do Momentum

CORPO · 02

FINALIDADE	Compreender quanto espaço físico, mental e prático existe hoje para sustentar mudanças. Momentum não é força de vontade, motivação nem obediência.
QUANDO É ÚTIL	Antes de aumentar a exigência; quando a paciente parece sobrecarregada; quando acordos anteriores não se sustentaram.
COMO FUNCIONA	Seis dimensões de 0 a 10 (energia disponível, carga de vida, controle sobre a rotina, suporte, espaço mental, estabilidade atual), o que sustenta, o que limita e o que **não é hora de pedir**. A nutricionista escolhe o estado: Preservar, Reorganizar, Construir ou Expandir. O sistema nunca sugere o estado.
O QUE PRODUZ	Um retrato da capacidade atual e o estado escolhido pela profissional, com o motivo.
COMO A NUTRICIONISTA USA	"Este estado ajuda a calibrar a exigência e a quantidade de mudanças propostas nesta etapa." Ele informa a Conduta; não a determina.
NO PRÓXIMO ATENDIMENTO	Ajuda a decidir se é hora de manter, reorganizar ou ampliar os acordos.
O QUE NÃO SIGNIFICA	Não é medida de energia biológica, nem avaliação de caráter ou de esforço.
LIMITES	Percepção da paciente lida pela nutricionista; não substitui avaliação clínica de cansaço persistente.

Mapa da Rotina

CORPO · 03

FINALIDADE	"Entender onde as dificuldades e as possibilidades de mudança aparecem na rotina real, antes de combinar mudanças que talvez não caibam no dia a dia."
QUANDO É ÚTIL	Quase sempre no começo: é a primeira sugestão do catálogo para os quatro sistemas físicos.
COMO FUNCIONA	Horários de acordar e dormir, sono, trabalho, deslocamentos, responsabilidades, momentos mais difíceis e mais disponíveis, espaços possíveis para mudança e uma lista de eventos do dia (horário, categoria, título, percepção, dias da semana).
O QUE PRODUZ	Um mapa descritivo do dia real, com os pontos de maior e menor dificuldade.
COMO A NUTRICIONISTA USA	"Essas informações ajudam a escolher mudanças que realmente caibam na rotina atual."
NO PRÓXIMO ATENDIMENTO	Os acordos são revistos contra o mesmo mapa; uma nova aplicação mostra a rotina depois das mudanças.
O QUE NÃO SIGNIFICA	Não é avaliação de disciplina nem diário alimentar quantitativo.
LIMITES	Registro estruturado: concluído, não é editado (cria-se uma nova aplicação).

MENTE

Mente: motivos, crenças e padrões

PQQ — Escada dos Porquês

MENTE · 01

FINALIDADE	"Compreender o que o objetivo desejado representa para a paciente e conectar a mudança a significados que façam sentido para ela."
QUANDO É ÚTIL	Quando o objetivo declarado é genérico ("emagrecer", "ter disposição") ou quando a mudança perde força depois das primeiras semanas.
COMO FUNCIONA	A partir do objetivo declarado, cinco níveis de "Pra que que você quer isso?", até o "pra que" verdadeiro.
O QUE PRODUZ	Uma escada de sentidos, nas palavras da paciente.
COMO A NUTRICIONISTA USA	"Essa síntese pode ajudar a manter as mudanças conectadas ao significado que a própria paciente atribui ao objetivo." Com o OQ[3], libera o Mapa do Propósito.
NO PRÓXIMO ATENDIMENTO	O "pra que" verdadeiro pode ser retomado quando a paciente desanima ou quando um acordo perde sentido.
O QUE NÃO SIGNIFICA	Não é interpretação psicológica. O sentido é o que a paciente declara.
LIMITES	Se a escada tocar em sofrimento que ultrapasse a nutrição, a nutricionista considera encaminhamento.

Mapa de Crenças Alimentares

MENTE · 02

FINALIDADE	Tornar visíveis ideias e regras sobre comida e corpo que podem estar influenciando escolhas.
QUANDO É ÚTIL	Quando aparecem frases como "não posso comer depois das 18h", "carboidrato engorda", "se eu sair da dieta, perdi tudo".
COMO FUNCIONA	Crenças que a paciente carrega, de onde vieram, qual mais atrapalha hoje e uma crença alternativa possível.
O QUE PRODUZ	Um registro das crenças nas palavras da paciente.
COMO A NUTRICIONISTA USA	"Esse registro ajuda a tornar visíveis ideias que podem estar influenciando escolhas alimentares e permite observá-las em situações reais."
NO PRÓXIMO ATENDIMENTO	A crença que mais atrapalha pode virar objeto de observação no dia a dia.
O QUE NÃO SIGNIFICA	Não é julgamento das crenças nem terapia cognitiva.
LIMITES	A nutricionista trabalha a relação com a comida dentro da sua competência.

Gatilhos & Respostas

MENTE · 03

FINALIDADE	"Tornar observável o que acontece antes e depois de determinado comportamento."
QUANDO É ÚTIL	Quando há comportamentos alimentares recorrentes difíceis de mudar: beliscar no fim da tarde, comer para se acalmar, comer escondido.
COMO FUNCIONA	Um episódio por aplicação: data, hora e contexto; gatilho; pensamento; emoção (com intensidade 0 a 10); resposta; consequências imediatas e posteriores; necessidade; observação da nutricionista; alternativa possível.
O QUE PRODUZ	A sequência de um episódio real, do gatilho à consequência.
COMO A NUTRICIONISTA USA	Para enxergar padrões ao longo de vários episódios e escolher onde uma alternativa pode caber.
NO PRÓXIMO ATENDIMENTO	Novos episódios mostram se o padrão se repete, muda ou perde força.
O QUE NÃO SIGNIFICA	Não afirma causa. Mostra uma sequência relatada, sem presumir que uma coisa provoca a outra.
LIMITES	Registro estruturado (não é editado depois de concluído). Não é avaliação de transtorno alimentar.

ESPÍRITO

Espírito: sentido, direção e pertencimento

Mapa do Propósito

ESPÍRITO · 01

FINALIDADE	Organizar direção e significado a partir do que a paciente já declarou no OQ³ e no PQQ.
QUANDO É ÚTIL	Depois do OQ³ e do PQQ, como aprofundamento opcional.
COMO FUNCIONA	Não é um formulário separado: é derivado do OQ³ e do PQQ ("Atualizar mapa"), com opção de imprimir ou salvar em PDF. É a única ligação automática entre ferramentas.
O QUE PRODUZ	Uma visão reunida do que a paciente quer, precisa, consegue e do sentido que atribui à mudança.
COMO A NUTRICIONISTA USA	Para conversar sobre direção quando o acompanhamento precisa de um eixo de sentido.
NO PRÓXIMO ATENDIMENTO	Pode ser atualizado quando o OQ³ ou o PQQ forem reaplicados.
O QUE NÃO SIGNIFICA	Não define a "missão" da paciente nem a sua espiritualidade.
LIMITES	Não há regra homologada de "direção desta etapa"; a leitura é da nutricionista.

Roda Holística da Vida

ESPÍRITO · 02

FINALIDADE	Ampliar o olhar para as áreas da vida que ocupam energia e espaço.
QUANDO É ÚTIL	Quando a alimentação parece "a ponta" de uma sobrecarga maior.
COMO FUNCIONA	Oito áreas de 0 a 10 (saúde, relações, trabalho, finanças, espiritualidade, lazer, desenvolvimento pessoal, propósito) e a pergunta "qual área está puxando as outras para baixo".
O QUE PRODUZ	As áreas percebidas como mais e menos cuidadas. **Não há média nem nota única.**
COMO A NUTRICIONISTA USA	"Essa percepção ajuda a escolher quais áreas merecem atenção neste momento."
NO PRÓXIMO ATENDIMENTO	Uma nova aplicação mostra como a percepção mudou, lado a lado.
O QUE NÃO SIGNIFICA	Não mede qualidade de vida nem bem-estar de forma validada.
LIMITES	Percepção da paciente naquele dia.

Carta ao Futuro Eu

ESPÍRITO · 03

FINALIDADE	Construir uma referência de identidade e direção futura para a mudança.
QUANDO É ÚTIL	Quando a paciente se define pelo que "sempre foi" ou quando a mudança precisa de um horizonte além do resultado imediato.
COMO FUNCIONA	"Para quando" e a carta, escrita pela paciente.
O QUE PRODUZ	Um texto pessoal. Na visão da paciente, aparece só que a carta "foi realizada como exercício de reflexão sobre identidade, direção e cuidado futuro": o conteúdo nunca é reproduzido.
COMO A NUTRICIONISTA USA	Como referência de conversa, com cuidado e com o consentimento da paciente.
NO PRÓXIMO ATENDIMENTO	Pode ser retomada em momentos de revisão do ciclo.
O QUE NÃO SIGNIFICA	Não é avaliada nem pontuada.
LIMITES	Conteúdo íntimo: tratar como tal.

Conexão & Pertencimento

ESPÍRITO · 04

FINALIDADE	Compreender como apoio, convivência e ambiente podem influenciar a sustentação dos hábitos.
QUANDO É ÚTIL	Quando a paciente se sente sozinha no processo, ou quando a família, o trabalho ou um grupo pesam nas escolhas.
COMO FUNCIONA	Campos sobre apoio e pertencimento, espiritualidade (opcional) e uma lista de relações: natureza, tipo, papel percebido (apoia, dificulta, neutro, variável) e proximidade.
O QUE PRODUZ	Um mapa de quem e do que sustenta a paciente, como ela descreve. Para a paciente, aparecem só contagens.
COMO A NUTRICIONISTA USA	"Essas informações ajudam a compreender quais recursos de apoio estão disponíveis durante o processo."
NO PRÓXIMO ATENDIMENTO	Ajuda a planejar acordos que contem com apoio real.
O QUE NÃO SIGNIFICA	Não avalia relações nem pessoas.
LIMITES	Registro estruturado (não é editado depois de concluído).

◆ ATENÇÃO METODOLÓGICA

Nenhuma ferramenta gera resultado automático interpretado. O sistema organiza o que foi registrado; a leitura é da nutricionista. Onde ainda não há texto aprovado sobre o significado de uma ferramenta, o sistema simplesmente não mostra o bloco, em vez de inventar uma interpretação.

Leitura profissional e Conduta

O método organiza; a nutricionista interpreta e decide. Essas duas etapas são dela.

Leitura profissional

A leitura profissional é o que a nutricionista entendeu, com as palavras dela. No HoloHacking ela aparece em três lugares:

ONDE	O QUE REGISTRA
HOLOSCAN → "Sua interpretação"	A leitura clínica da aplicação. Fica guardada junto do HOLOSCAN e vai para o relatório.
Cada ferramenta → "Leitura profissional"	"O que chamou atenção", "Prioridade" e "Próximo passo" (em sete ferramentas do catálogo).
Resultado HOLOS → observações	"Leitura profissional da nutricionista", "Pontos para acompanhar" e "Questões para aprofundar" (esta última só na visão profissional).

> *A leitura profissional nunca é gerada pelo sistema. Ela é escrita pela nutricionista.*

Conduta

A Conduta registra o que foi decidido para a etapa. Ela pertence a um atendimento e tem revisões: depois de salva, não é editada; uma mudança vira nova revisão.

CAMPO	PARA QUE SERVE
Prioridades selecionadas	O que esta etapa vai priorizar.
Objetivo da etapa	O que se quer alcançar até o próximo encontro, em linguagem simples.
Estratégia nutricional	O caminho escolhido para chegar lá.
Ações	O que a paciente vai experimentar.
Recursos	Materiais e apoios combinados.
Exames solicitados (quando pertinente)	Registro administrativo; exames não entram no HOLOSCAN nem no Resultado HOLOS.
Monitoramento e Retorno	O que observar e quando reavaliar.
Orientações profissionais e Observações	O que a nutricionista quer deixar registrado.

CAMPO	PARA QUE SERVE
Ferramentas relacionadas	As ferramentas que embasaram a decisão.
Acordos	Cada acordo tem descrição, responsável, prazo, acompanhamento e estado: Proposto, Acordado, Em acompanhamento, Concluído, Revisto ou Encerrado.

O QUE O SISTEMA FAZ

- Nenhum campo é obrigatório. A Conduta não depende de nota, faixa, Índice, HOLOSCAN completo nem ferramenta.
- No retorno, a Conduta anterior aparece ao lado, com a opção "Levar acordos para esta conduta" e a decisão de continuar, substituir ou encerrar cada acordo. Nada é levado automaticamente.
- O sistema não gera dieta, diagnóstico nutricional nem encaminhamento.

O QUE A NUTRICIONISTA DECIDE

A Conduta é **da nutricionista**. O HOLOSCAN e as ferramentas informam a decisão; não a determinam.

Resultado HOLOS

O momento em que o que foi registrado vira uma síntese organizada, com uma versão para a nutricionista e outra para a paciente.

A arquitetura do resultado

Cada parte do Resultado HOLOS segue a mesma lógica, do dado ao próximo passo:

DADO → RESULTADO → SIGNIFICADO → PORQUÊ → APROFUNDAMENTO → PRÓXIMO PASSO

Para cada sistema, por exemplo, o Resultado mostra: o que o eixo organiza; a nota nesta aplicação; o que mais contribuiu; o que isso significa dentro do HOLOSCAN; o que **não** significa; o que pode merecer aprofundamento; e o próximo passo pelo catálogo.

Três camadas que não se misturam

O QUE O SISTEMA FAZ

Resultado do método

Notas, Índice, Tríade, áreas para aprofundar, sinais e ferramentas sugeridas. É calculado pela regra do método a partir das respostas da paciente: muda quando as respostas mudam.

O QUE A NUTRICIONISTA DECIDE

Leitura profissional

O que a nutricionista entendeu ao juntar o método, a conversa e o contexto. Escrita por ela.

RESULTADO DESTA ETAPA

Conduta

O que foi decidido e combinado para a etapa. Também da nutricionista, com a paciente.

Resultado do método ≠ leitura profissional ≠ Conduta

CADA CAMADA TEM UM AUTOR DIFERENTE

Como o Resultado HOLOS é gerado

Na aba "Resultado HOLOS" da ficha, "Gerar Resultado HOLOS" abre um formulário em que a nutricionista escolhe:

1. o **atendimento**;
2. a **aplicação do HOLOSCAN** (oficial);
3. as **ferramentas concluídas** que entram, cada uma com a opção "Mostrar ao paciente";
4. se os **Próximos Passos HOLOS** serão compartilhados com a paciente (desligado por padrão);
5. as três **observações**: leitura profissional, pontos para acompanhar e questões para aprofundar.

Depois vêm "Pré-visualizar", "Salvar rascunho" e "Salvar Resultado HOLOS". Um resultado salvo fica congelado; ele pode ser marcado como revisado, e uma mudança vira **nova versão**, com o histórico preservado.

◆ ATENÇÃO METODOLÓGICA

Não existe fórmula que junte Corpo, Mente e Espírito numa conclusão automática. O Resultado organiza; quem integra é a nutricionista.

O que a nutricionista vê

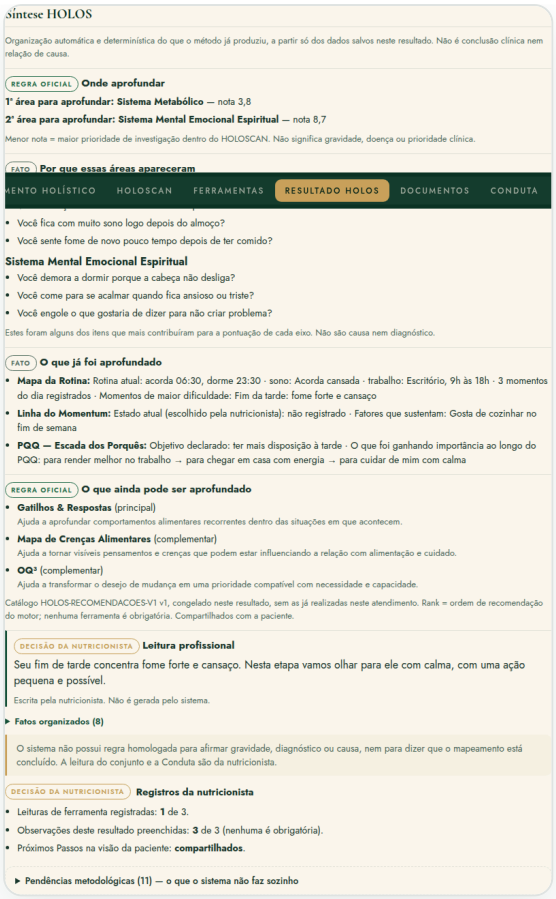
A visão profissional reúne tudo o que é preciso para decidir, com a separação clara entre o que pontuou e o que é só contexto.

As seções da visão profissional

SEÇÃO	O QUE MOSTRA
Resumo para decisão	1ª e 2ª área para aprofundar, próximo passo principal, ferramentas complementares, ferramentas já aplicadas e estado do processo.
Por que o sistema chegou a isso	Visão geral do HOLOSCAN e os cinco sistemas, cada um com "Pontuou neste sistema" e "Contexto, sem pontuar".
Resultados das ferramentas	Por território, com o panorama das ferramentas aplicadas.
Síntese HOLOS	Onde aprofundar, por que essas áreas apareceram, o que já foi aprofundado, o que ainda pode ser aprofundado, leitura profissional.
Leitura profissional	As observações da nutricionista.
Conduta	Atalho para a Conduta do atendimento.



O QUE A NUTRICIONISTA VÊ O topo do Resultado HOLOS profissional: dados da aplicação, pacote metodológico (HOLOS-V1 v6) e o "Resumo para decisão" (paciente fictícia).



O QUE A NUTRICIONISTA VÊ A Síntese HOLOS: organização determinística do que o método produziu, separando regra oficial, fato e decisão da nutricionista.

NA PRÁTICA

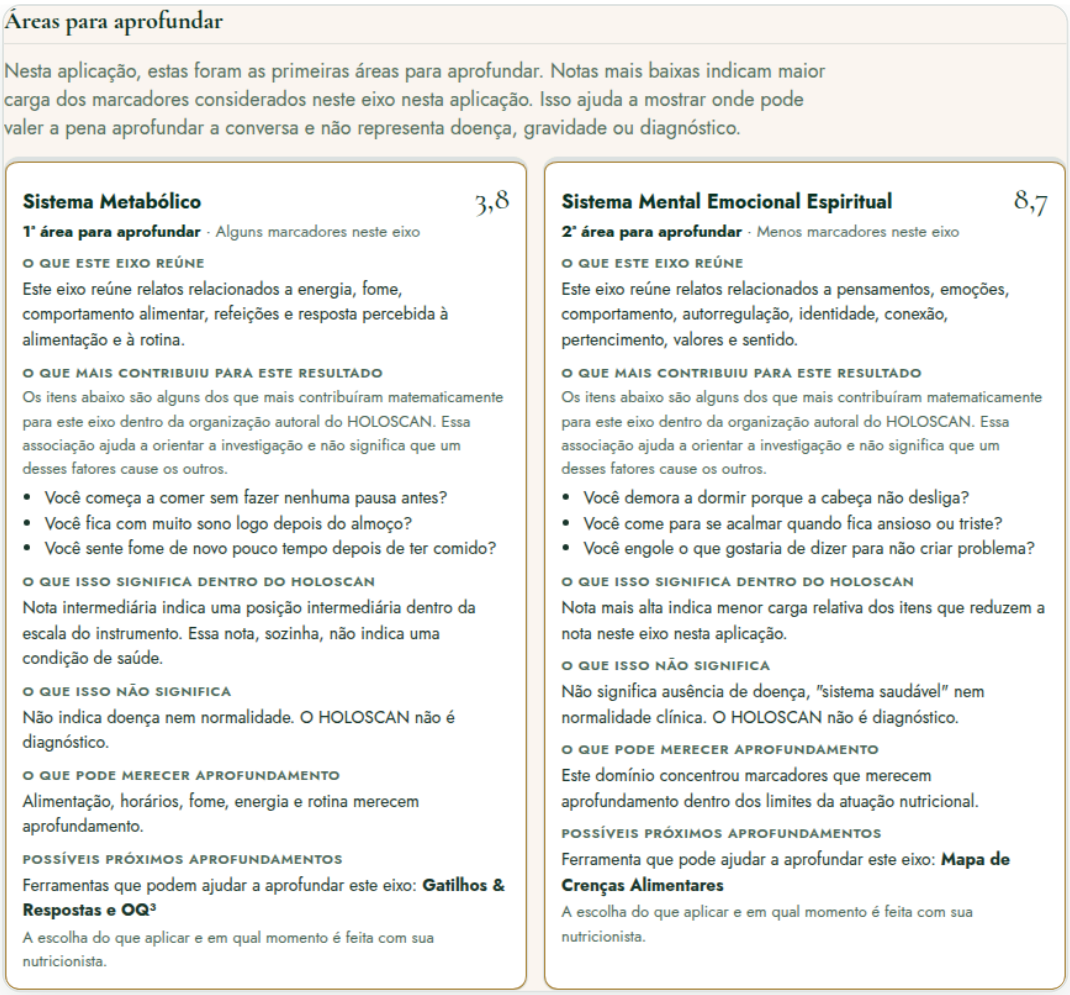
Quando um sistema aparece na 2ª posição sem ter tido nenhuma carga (nota 10,0), a visão profissional avisa que ele está ali **só pela ordem oficial de desempate**. Isso evita ler como prioridade algo que a paciente não relatou.

O que a paciente recebe

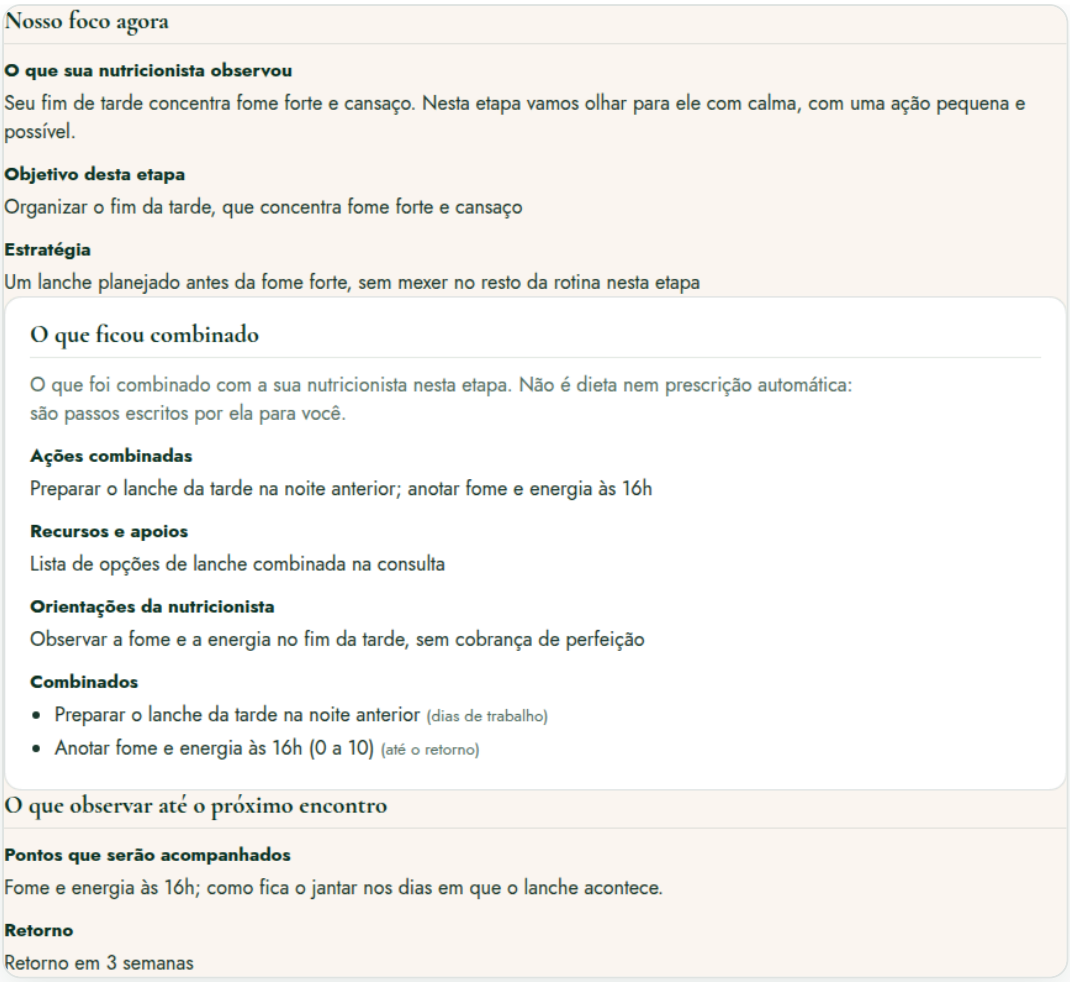
Uma versão em linguagem humana: o que apareceu, o que isso significa, o que não significa, e o que foi combinado.

As seções da visão da paciente ("Seu Mapa HOLOS")

SEÇÃO	O QUE A PACIENTE ENTENDE
O que entendemos nesta etapa	Onde o acompanhamento está focado e quais ferramentas foram feitas.
Áreas para aprofundar	As áreas que aparecem primeiro, com o que cada eixo reúne, o que mais contribuiu, o que significa e o que não significa.
O que descobrimos com as ferramentas	O que foi aprendido, só das ferramentas que a nutricionista escolheu mostrar.
Nosso foco agora	A leitura que a nutricionista escreveu para ela.
O que ficou combinado	Objetivo, estratégia, ações e acordos da Conduta.
O que observar até o próximo encontro	Os pontos para acompanhar.
Detalhes do mapa	Os cinco sistemas, o Índice e a Tríade, para quem quiser ver.



O QUE A PACIENTE RECEBE "Áreas para aprofundar" na visão da paciente (paciente fictícia). O contexto sem pontuação não aparece aqui, para não parecer o motivo da nota.



O QUE A PACIENTE RECEBE O foco, o que ficou combinado e o que observar até o próximo encontro.

O QUE A PACIENTE PERCEBE

- Ela lê **o que apareceu** e **o que isso não significa** na mesma página.
- Não vê cobertura técnica, pendências metodológicas nem as questões internas da nutricionista.
- Não recebe diagnóstico, nem frases de causa e efeito entre emoção e corpo.

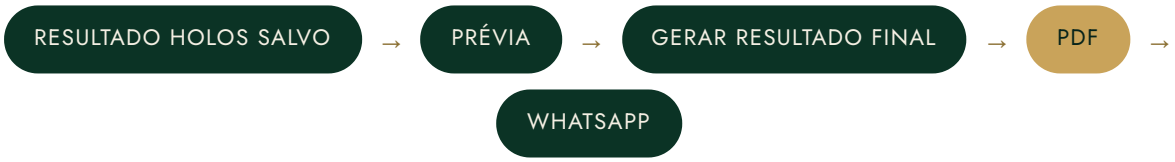
Resultado Final, PDF e WhatsApp

Do resultado preparado na ficha à entrega para a paciente.

Resultado HOLOS e Resultado Final: qual é a diferença

	RESULTADO HOLOS	RESULTADO FINAL
Onde	Aba "Resultado HOLOS" da ficha	Menu "Resultado"
O que é	A síntese clínica da etapa, com visão profissional e visão da paciente	A **emissão** para a paciente: congela o Resultado HOLOS (visão da paciente), a Conduta do mesmo atendimento e a identidade profissional do Perfil
Pode mudar?	Sim, por nova versão	Não: cada emissão é imutável; uma mudança vira nova emissão
PDF	"Imprimir ou salvar em PDF" (impressão do navegador)	"Baixar PDF" e "Imprimir"

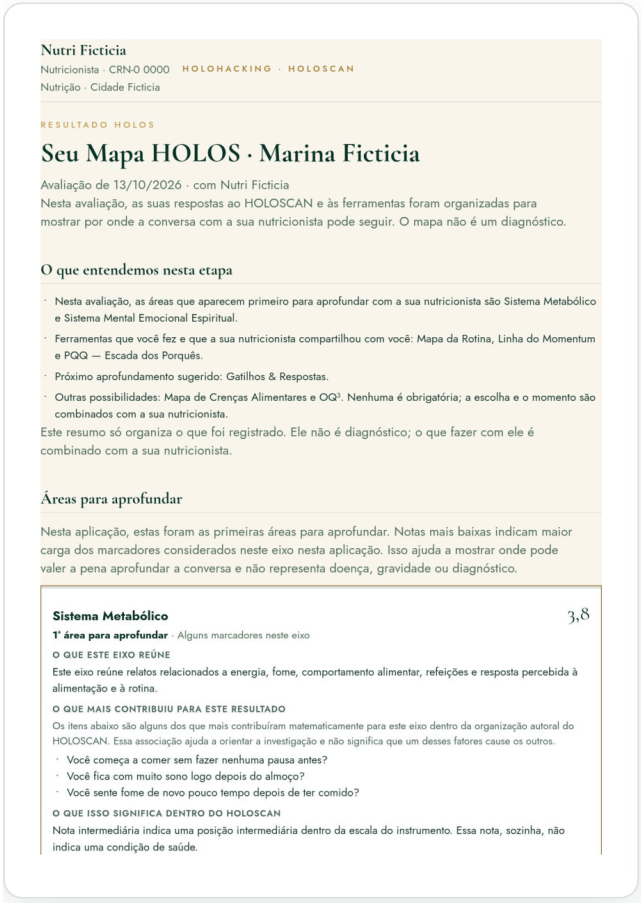
O fluxo de entrega



1. Na página "Resultado", a nutricionista vê a **PRÉVIA** do que a paciente vai receber.
2. **"Gerar Resultado Final"** congela o conteúdo: "Resultado Final nº X · conteúdo congelado".
3. **"Baixar PDF"** gera o arquivo no próprio navegador, com o nome, o registro profissional, o logo, a assinatura e o carimbo do Perfil.
4. **"Enviar pelo WhatsApp"**: no celular, abre o compartilhamento com o PDF anexado; no computador, baixa o PDF e abre a conversa com a mensagem pronta, e a nutricionista anexa o arquivo.



O QUE A NUTRICIONISTA VÊ Um Resultado Final emitido: conteúdo congelado, com Baixar PDF, Enviar pelo WhatsApp, Imprimir, Abrir na ficha e Gerar nova emissão (paciente fictícia).


Nutri Ficticia
Nutricionista · CRN-0 0000 HOLOHACKING · HOLOSCAN
Nutrição · Cidade Ficticia

RESULTADO HOLOS

Seu Mapa HOLOS · Marina Ficticia

Avaliação de 13/10/2026 · com Nutri Ficticia
Nesta avaliação, as suas respostas ao HOLOSCAN e às ferramentas foram organizadas para mostrar por onde a conversa com a sua nutricionista pode seguir. O mapa não é um diagnóstico.

O que entendemos nesta etapa

- Nesta avaliação, as áreas que aparecem primeiro para aprofundar com a sua nutricionista são Sistema Metabólico e Sistema Mental Emocional Espiritual.
- Ferramentas que você fez e que a sua nutricionista compartilhou com você: Mapa da Rotina, Linha do Momentum e PQG — Escada dos Porquês.
- Próximo aprofundamento sugerido: Gatilhos & Respostas.
- Outras possibilidades: Mapa de Crenças Alimentares e OQ³. Nenhuma é obrigatória; a escolha e o momento são combinados com a sua nutricionista.

Este resumo só organiza o que foi registrado. Ele não é diagnóstico; o que fazer com ele é combinado com a sua nutricionista.

Áreas para aprofundar

Nesta aplicação, estas foram as primeiras áreas para aprofundar. Notas mais baixas indicam maior carga dos marcadores considerados neste eixo nesta aplicação. Isso ajuda a mostrar onde pode valer a pena aprofundar a conversa e não representa doença, gravidade ou diagnóstico.

Sistema Metabólico 3,8
1ª área para aprofundar · Alguns marcadores neste eixo

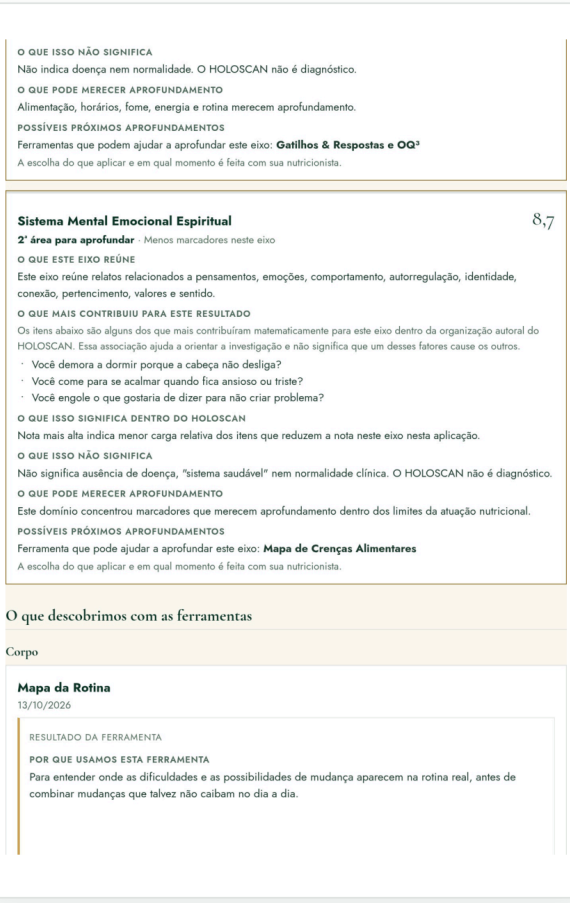
O QUE ESTE EIXO REÚNE
Este eixo reúne relatos relacionados a energia, fome, comportamento alimentar, refeições e resposta percebida à alimentação e à rotina.

O QUE MAIS CONTRIBUIU PARA ESTE RESULTADO
Os itens abaixo são alguns dos que mais contribuíram matematicamente para este eixo dentro da organização autoral do HOLOSCAN. Essa associação ajuda a orientar a investigação e não significa que um desses fatores cause os outros.

- Você começa a comer sem fazer nenhuma pausa antes?
- Você fica com muito sono logo depois do almoço?
- Você sente fome de novo pouco tempo depois de ter comido?

O QUE ISSO SIGNIFICA DENTRO DO HOLOSCAN
Nota intermediária indica uma posição intermediária dentro da escala do instrumento. Essa nota, sozinha, não indica uma condição de saúde.

O QUE A PACIENTE RECEBE Primeira página do PDF.


O QUE ISSO NÃO SIGNIFICA
Não indica doença nem normalidade. O HOLOSCAN não é diagnóstico.

O QUE PODE MERECER APROFUNDAMENTO
Alimentação, horários, fome, energia e rotina merecem aprofundamento.

POSSÍVEIS PRÓXIMOS APROFUNDAMENTOS
Ferramentas que podem ajudar a aprofundar este eixo: **Gatilhos & Respostas e OQ³**
A escolha do que aplicar e em qual momento é feita com sua nutricionista.

Sistema Mental Emocional Espiritual 8,7
2ª área para aprofundar · Menos marcadores neste eixo

O QUE ESTE EIXO REÚNE
Este eixo reúne relatos relacionados a pensamentos, emoções, comportamento, autorregulação, identidade, conexão, pertencimento, valores e sentido.

O QUE MAIS CONTRIBUIU PARA ESTE RESULTADO
Os itens abaixo são alguns dos que mais contribuíram matematicamente para este eixo dentro da organização autoral do HOLOSCAN. Essa associação ajuda a orientar a investigação e não significa que um desses fatores cause os outros.

- Você demora a dormir porque a cabeça não desliga?
- Você come para se acalmar quando fica ansioso ou triste?
- Você engole o que gostaria de dizer para não criar problema?

O QUE ISSO SIGNIFICA DENTRO DO HOLOSCAN
Nota mais alta indica menor carga relativa dos itens que reduzem a nota neste eixo nesta aplicação.

O QUE ISSO NÃO SIGNIFICA
Não significa ausência de doença, "sistema saudável" nem normalidade clínica. O HOLOSCAN não é diagnóstico.

O QUE PODE MERECER APROFUNDAMENTO
Este domínio concentrou marcadores que merecem aprofundamento dentro dos limites da atuação nutricional.

POSSÍVEIS PRÓXIMOS APROFUNDAMENTOS
Ferramenta que pode ajudar a aprofundar este eixo: **Mapa de Crenças Alimentares**
A escolha do que aplicar e em qual momento é feita com sua nutricionista.

O que descobrimos com as ferramentas

Corpo

Mapa da Rotina
13/10/2026

RESULTADO DA FERRAMENTA

POR QUE USAMOS ESTA FERRAMENTA
Para entender onde as dificuldades e as possibilidades de mudança aparecem na rotina real, antes de combinar mudanças que talvez não caibam no dia a dia.

O QUE A PACIENTE RECEBE Segunda página do PDF.

O QUE O SISTEMA FAZ

- **Nenhum link é enviado.** O PDF é gerado no navegador, sem página pública.
- Emissões anteriores ficam em "Emissões deste paciente".
- A mensagem do WhatsApp diz: *"Olá, [nome]! Segue o seu Resultado HOLOS ([data]). Ele organiza o que registramos na sua avaliação e os próximos passos que combinamos. Qualquer dúvida, é só me chamar."*

Outros registros que acompanham a jornada

REGISTRO	O QUE FAZ	O QUE NÃO FAZ
Relatórios clínicos	Relatório profissional com fontes escolhidas uma a uma; prévia, rascunho e emissão imutável (retificação gera nova emissão).	Não interpreta exames.
Documentos	Guarda exames, laudos, receitas e outros arquivos (até 10 MB), com tipo, título e data.	Não lê nem interpreta os arquivos; eles não entram no HOLOSCAN nem no Resultado.
Linha do tempo	Mostra os registros consolidados, com filtros por tipo.	Não cria registro novo.
HOLOS AI	Monta um texto de contexto do caso para a nutricionista copiar.	Não envia nada sozinho; a abertura direta em assistentes externos está "Em desenvolvimento".

Retornos: o princípio fundamental

Uma jornada de até 10 atendimentos não é um protocolo. É um exemplo de caminho possível, que cada nutricionista adapta a cada paciente.

Este é um exemplo de jornada possível. A escolha depende do caso.
A nutricionista interpreta e decide.

PRINCÍPIO DOS RETORNOS

O que este capítulo não diz

◆ ATENÇÃO METODOLÓGICA

- Não diz que a consulta 1 usa obrigatoriamente a ferramenta X e a consulta 2 a ferramenta Y.
- Não define intervalo entre consultas nem entre aplicações do HOLOSCAN.
- Não obriga alternar Corpo, Mente e Espírito.
- Não promete resultado clínico em nenhum número de consultas.

O que o HoloHacking já oferece para os retornos

RECURSO	COMO AJUDA NO RETORNO
Agenda	Tipos "Retorno" e "Reavaliação HOLOSCAN"; reagendar mantém o original no histórico.
Mapeamento de retorno	Enviado automaticamente no formato curto "Desde a última consulta" quando a paciente já tem Mapeamento concluído.
Mapeamento profissional de retorno	Tipo "Retorno", com o bloco "Desde a última consulta".
Conduta anterior	Aparece ao lado, com "Levar acordos para esta conduta" e a decisão de continuar, substituir ou encerrar cada acordo.
Nova aplicação	HOLOSCAN e ferramentas podem ser reaplicados; o histórico de cada um fica preservado.
Resultado HOLOS	Uma nova aplicação gera uma nova versão do Resultado; as anteriores ficam guardadas.

RECURSO	COMO AJUDA NO RETORNO
Evolução	Compara lado a lado: atendimento anterior × atual, linha de base × atual, dois atendimentos ou duas datas.
Dashboard	Mostra em que etapa cada paciente está (Aguardando Mapeamento, Mapeamento recebido, HOLOSCAN em andamento, Resultado pronto, Resultado apresentado, Aguardando retorno).

◆ ATENÇÃO METODOLÓGICA

Evolução mostra lado a lado, sem calcular diferenças de nota, Índice, Tríade ou faixa. A regra de comparabilidade entre aplicações ainda não foi homologada. Aplicações feitas em versões diferentes do pacote metodológico **não são comparadas como se fossem equivalentes**.

✧ VISÃO FUTURA / EXPERIÊNCIA DESEJADA

O HoloHacking ainda **não organiza a jornada em ciclos** (contagem de atendimentos, marcos de ciclo, síntese de fechamento). Hoje, o ciclo existe na condução da nutricionista e no histórico registrado; não há uma função de "ciclo".

Mapa de um ciclo de até 10 atendimentos

Uma estrutura narrativa para pensar o acompanhamento ao longo do tempo. Não é regra clínica.

1. **Compreender e priorizar**
   Criar um ponto de partida organizado.
2. **Aprofundar**
   Entender melhor o padrão que apareceu primeiro.
3. **Testar e observar**
   Ver o que aconteceu quando os acordos encontraram a vida real.
4. **Integrar**
   Conectar alimentação, rotina, comportamento, emoção e contexto.
5. **Revisar o primeiro ciclo**
   Um checkpoint: de onde partimos, o que mudou, o que permanece.
6. **Aprofundar uma nova camada**
   Ir além do primeiro foco, sem repetir a primeira consulta.
7. **Consolidar**
   Consistência, sustentabilidade e pequenos ajustes.
8. **Autonomia**
   A paciente começa a reconhecer os próprios padrões.
9. **Reavaliação global**
   Início versus momento atual, com respeito ao versionamento.
10. **Fechamento do ciclo e próxima fase**
    Síntese, conquistas, o que continuar e como seguir.

NA PRÁTICA

Um ciclo pode ter menos encontros, pode pular etapas ou voltar a uma delas. Uma paciente pode precisar de três consultas de "aprofundar" antes de "testar"; outra pode chegar à autonomia cedo. A numeração ajuda a pensar, não a cobrar.

Os 10 atendimentos, um a um

Para cada encontro: o que revisar antes, o que fazer durante, o que registrar depois, o objetivo e o resultado esperado do processo.

Atendimento 1 — Compreender e priorizar

NA PRÁTICA

Antes - Mapeamento recebido e lido. - Revisão do contexto: queixa, objetivo, rotina, sinais relatados.

Durante - Conversa. - HOLOSCAN, quando pertinente. - Leitura das áreas para aprofundar. - Escolha do primeiro aprofundamento e, se couber, aplicação de uma ferramenta.

Depois - Leitura profissional, Conduta e acordos. - Resultado para a paciente.

O QUE A NUTRICIONISTA DECIDE

Objetivo do encontro: criar um ponto de partida organizado.

RESULTADO DESTA ETAPA

Resultado esperado do processo: a paciente entende qual é o foco inicial e o que observar até o retorno.

O QUE O SISTEMA FAZ

Atendimento aberto · Mapeamento levado para o atendimento · HOLOSCAN salvo · ferramenta concluída (se houver) · Conduta · Resultado HOLOS · Resultado Final em PDF.

Atendimento 2 — Aprofundar

Revisar os acordos, a percepção da paciente, as barreiras, as mudanças observadas e a ferramenta anterior.

> *O primeiro aprofundamento respondeu à pergunta que motivou a escolha?*

Possibilidades:

- continuar no mesmo eixo, com outra ferramenta do mesmo sistema;
- aplicar uma ferramenta complementar sugerida no primeiro resultado;
- mudar para a segunda área para aprofundar;
- aprofundar Corpo, Mente ou Espírito conforme a conversa pedir.

O QUE O SISTEMA FAZ

Mapeamento de retorno · Conduta anterior ao lado da nova · "Próximos Passos HOLOS" do primeiro resultado (sem as ferramentas já feitas) · nova ferramenta.

RESULTADO DESTA ETAPA

Mais clareza sobre o padrão investigado.

Atendimento 3 — Testar e observar

O foco é o que aconteceu quando os acordos encontraram a vida real: o que foi tentado, o que aconteceu, adesão, barreiras, contexto e aprendizado.

- Comparar o resultado de uma ferramenta com o da aplicação anterior, lado a lado.
- Reaplicar uma ferramenta, **quando isso fizer sentido** (não há regra automática de reaplicação).
- Usar outra ferramenta.
- Atualizar a Conduta: continuar, substituir ou encerrar cada acordo.

RESULTADO DESTA ETAPA

A paciente vê que "não deu certo" também é informação, e a Conduta passa a refletir o que é possível de verdade.

Atendimento 4 — Integrar

Começar a conectar alimentação, rotina, comportamento, emoções, contexto, prioridades e as respostas aos acordos. A aba Evolução ajuda a ver o caminho até aqui, lado a lado.

> *O que estamos entendendo agora que não estava claro no início?*

RESULTADO DESTA ETAPA

Uma leitura mais integrada da paciente, registrada pela nutricionista, que conecta o que antes parecia solto.

Atendimento 5 — Revisão do primeiro ciclo

Um checkpoint. Rever o ponto de partida, as áreas iniciais, as ferramentas usadas, os acordos, as mudanças percebidas, as dificuldades que persistem, o aprendizado da paciente e a necessidade de novo aprofundamento.

Quando considerar uma nova aplicação do HOLOSCAN? Por exemplo, quando a conversa sugere que o retrato inicial mudou, quando a paciente relata mudanças importantes de rotina ou de momento de vida, ou quando a nutricionista quer revisar as áreas para aprofundar com dados novos.

◆ ATENÇÃO METODOLÓGICA

A reaplicação é decisão profissional e contextual, até que uma regra oficial de periodicidade seja definida. O HoloHacking não sugere nem exige intervalo. A Agenda tem o tipo "Reavaliação HOLOSCAN" para quando a nutricionista decidir.

Atendimento 6 — Aprofundar uma nova camada

Depois do primeiro ciclo: aprofundar algo que permaneceu, investigar a segunda prioridade, trabalhar uma barreira nova ou usar outra ferramenta quando pertinente.

NA PRÁTICA

O acompanhamento não precisa repetir a primeira consulta. O que já está registrado (Mapeamento, HOLOSCAN, ferramentas, Condutas) continua disponível; o novo encontro parte dali.

Atendimento 7 — Consolidar

Foco em consistência, sustentabilidade, obstáculos recorrentes, autonomia e pequenos ajustes. Ferramentas podem ser revisitadas quando agregarem informação.

RESULTADO DESTA ETAPA

Acordos que já se sustentam saem do foco; os que ainda pesam são simplificados.

Atendimento 8 — Autonomia

No início

A nutricionista ajuda a organizar e a enxergar.

Mais adiante

A paciente começa a reconhecer os próprios padrões.

Possíveis resultados do processo: maior percepção, capacidade de antecipar gatilhos, mais consciência das escolhas, rotina mais coerente, decisões mais autônomas.

◆ ATENÇÃO METODOLÓGICA

Esses são resultados possíveis **do processo**, não promessas de resultado clínico.

Atendimento 9 — Reavaliação global

Rever a jornada completa: **início versus momento atual**.

- Nova aplicação do HOLOSCAN, se profissionalmente indicada.
- Comparação descritiva, lado a lado, na aba Evolução.
- Ferramentas anteriores, Condutas e acordos.
- Percepção da paciente e mudanças observáveis.

◆ ATENÇÃO METODOLÓGICA

Respeitar o versionamento. Se a primeira aplicação foi feita numa versão anterior do pacote metodológico, os números não são comparados como se fossem equivalentes. A Evolução mostra lado a lado, sem diferença calculada.

Atendimento 10 — Fechamento do ciclo e próxima fase

Uma consulta de síntese. Perguntas que orientam:

- De onde partimos?
- O que aprendemos?
- Quais padrões ficaram claros?
- O que mudou?
- O que permanece?
- Quais estratégias foram sustentáveis?
- O que a paciente já conduz com mais autonomia?
- Existe nova prioridade?
- Precisamos de um novo ciclo?
- O intervalo entre consultas pode aumentar?
- O acompanhamento entra em manutenção?
- Existe necessidade de outro profissional?

O que o fechamento produz:

BLOCO	CONTEÚDO
Síntese do ciclo	De onde partimos, o caminho percorrido, o que foi aprendido.
Foco atual	O que continua importante agora.
Conquistas e mudanças observadas	Nas palavras da paciente e no registro da nutricionista.
Pontos a continuar observando	O que ainda pede atenção.
Plano para a próxima fase	Novo ciclo, manutenção, intervalo maior ou encaminhamento.

O QUE O SISTEMA FAZ

Hoje, o fechamento pode ser registrado com os recursos existentes: a **Conduta** do atendimento (objetivo, orientações, retorno), as **observações do Resultado HOLOS** e um **Relatório clínico** emitido com as fontes escolhidas.

✧ VISÃO FUTURA / EXPERIÊNCIA DESEJADA

Um documento próprio de **Síntese do Ciclo**, gerado a partir do histórico e editado pela nutricionista, ainda não existe no produto.

Resultados esperados de um ciclo

O que um ciclo de acompanhamento pode produzir, descrito como resultado do processo, não como promessa.

◆ ATENÇÃO METODOLÓGICA

Este capítulo **não promete** cura, perda de peso, reversão de doença, melhora hormonal, melhora metabólica nem qualquer resultado clínico garantido.

RESULTADO DESTA ETAPA

Resultados de compreensão - Maior compreensão da própria rotina. - Identificação de padrões alimentares. - Reconhecimento de gatilhos. - Mais clareza sobre fome e saciedade, quando pertinente. - Melhor compreensão das próprias barreiras.

RESULTADO DESTA ETAPA

Resultados de comportamento - Maior consciência das escolhas. - Estratégias mais realistas, que cabem na rotina. - Capacidade de perceber recaídas sem transformar tudo em fracasso.

RESULTADO DESTA ETAPA

Resultados de autonomia - Mais autonomia nas decisões do dia a dia. - Maior participação na construção da própria Conduta. - Capacidade de antecipar situações difíceis.

RESULTADO DESTA ETAPA

Resultados do acompanhamento - Histórico organizado do processo. - Clareza sobre o que funcionou e o que não funcionou. - Próximos passos definidos.

◆ ATENÇÃO METODOLÓGICA

Resultados clínicos. Resultados clínicos dependem do quadro individual, avaliação profissional, adesão, contexto e outros fatores e não são garantidos pelo método ou pela plataforma.

Caso fictício: Marina

Uma paciente inventada, acompanhada pela mesma nutricionista ao longo de dez encontros. A história tem avanços, recaídas e ajustes, como costuma acontecer.

◆ ATENÇÃO METODOLÓGICA

Marina é fictícia. Nome, idade, rotina, relatos e números foram criados para este documento. Nada aqui é diagnóstico, e nenhuma escolha de ferramenta é regra: são decisões possíveis de uma nutricionista diante deste caso.

Quem é Marina

Marina tem 37 anos, trabalha num escritório das 9h às 18h e mora com o companheiro e um filho de 6 anos. Procurou acompanhamento porque quer **"ter mais energia à tarde e parar de beliscar à noite"**. Já fez dietas antes e "sempre largou no meio". Acorda cansada, almoça rápido, sente fome forte no fim da tarde e, à noite, come "o que tiver" enquanto organiza a casa.

1 Compreender e priorizar

PRIMEIRA CONSULTA

ENTRADA	Mapeamento enviado pelo WhatsApp três dias antes e respondido em uma noite. Na consulta, a nutricionista abre o atendimento e leva o Mapeamento para o atendimento.
O QUE ELA RELATA	Sono que não descansa, almoço corrido, fome forte às 16h30, beliscar à noite "para relaxar", culpa depois.
O QUE A NUTRICIONISTA ORGANIZA	Aplica o HOLOSCAN. A 1ª área para aprofundar é o Sistema Metabólico (nota 3,8); a 2ª, o Sistema Mental Emocional Espiritual (8,7). Os sinais que mais pontuaram no Metabólico: começar a comer sem pausa, sono depois do almoço, fome pouco depois de comer.
PARTE DO SISTEMA	Mapeamento Holístico, HOLOSCAN, Próximos Passos HOLOS, Mapa da Rotina, Conduta, Resultado HOLOS, Resultado Final.
FERRAMENTA	**Mapa da Rotina** (principal sugerida pelo catálogo para o Metabólico).
POR QUE ESTA	A conversa confirmou que o problema "acontece no relógio": a ferramenta ajuda a localizar onde a fome e o cansaço aparecem no dia real, antes de combinar qualquer mudança.
O QUE FOI APRENDIDO	O fim da tarde concentra fome forte e cansaço; o almoço é o momento mais estável; a manhã é corrida.
CONDUTA / ACORDO	Objetivo: organizar o fim da tarde. Acordos: preparar o lanche da tarde na noite anterior; anotar fome e energia às 16h (0 a 10).
ATÉ O PRÓXIMO ENCONTRO	Como fica o jantar nos dias em que o lanche acontece.
HISTÓRICO	Primeiro atendimento, primeiro HOLOSCAN (HOLOS-V1 v6), primeira Conduta e Resultado Final nº 1 enviado em PDF.

2 Aprofundar

RETORNO · 3 SEMANAS DEPOIS

ENTRADA	Mapeamento de retorno ("Desde a última consulta") respondido na véspera.
O QUE ELA RELATA	Conseguiu o lanche em dois de cinco dias. Nos dias com lanche, chegou menos faminta. À noite, continua beliscando quando chega cansada.
O QUE A NUTRICIONISTA ORGANIZA	O primeiro aprofundamento respondeu à pergunta da tarde; a noite ainda está em aberto. A complementar sugerida no primeiro resultado foi Gatilhos & Respostas.
PARTE DO SISTEMA	Mapeamento de retorno, Conduta anterior ao lado, Gatilhos & Respostas.
FERRAMENTA	**Gatilhos & Respostas**, com um episódio da noite anterior.
POR QUE ESTA	O beliscar noturno é um comportamento recorrente; a ferramenta torna observável o que acontece antes e depois dele.
O QUE FOI APRENDIDO	Gatilho: chegar em casa e ver a louça; pensamento "não vou dar conta"; emoção: cansaço e irritação (7/10); resposta: comer de pé, beliscando; depois, culpa.
CONDUTA / ACORDO	Continuar o lanche da tarde. Novo acordo: ao chegar, sentar e comer algo planejado antes de começar as tarefas da casa.
ATÉ O PRÓXIMO ENCONTRO	Registrar mais dois episódios, se acontecerem.
HISTÓRICO	Segunda Conduta (com os acordos anteriores revistos), primeira aplicação de Gatilhos & Respostas.

3 Testar e observar

RETORNO

ENTRADA	Mapeamento de retorno. Marina avisa que a semana foi difícil.
O QUE ELA RELATA	O filho ficou doente; ela "desandou tudo". O lanche da tarde se manteve em três dias; a noite piorou.
O QUE A NUTRICIONISTA ORGANIZA	A semana trouxe uma carga de vida maior. Antes de pedir mais, vale entender quanto espaço existe agora.
PARTE DO SISTEMA	Linha do Momentum, Conduta.
FERRAMENTA	**Linha do Momentum**. Estado escolhido pela nutricionista: **Reorganizar**.
POR QUE ESTA	Ajuda a calibrar a exigência quando os acordos não se sustentaram por falta de espaço, não de vontade.
O QUE FOI APRENDIDO	Energia disponível baixa, carga de vida alta, suporte médio. O que não é hora de pedir: mudanças no jantar da família.
CONDUTA / ACORDO	Manter só o lanche da tarde. O acordo da noite fica "em acompanhamento", sem cobrança.
ATÉ O PRÓXIMO ENCONTRO	Perceber o que torna os dias com lanche possíveis.
HISTÓRICO	Uma recaída registrada como informação, não como fracasso.

4 Integrar

RETORNO

ENTRADA	Marina chega mais tranquila. O lanche aconteceu em quatro de cinco dias.
O QUE ELA RELATA	Nos dias com lanche, o jantar fica mais calmo. Diz que quer "dar conta" sem se sentir

	sempre atrasada.
O QUE A NUTRICIONISTA ORGANIZA	Começa a conectar rotina, fome, cansaço e o desejo de "dar conta". A Evolução mostra as Condutas e as ferramentas lado a lado.
PARTE DO SISTEMA	PQQ, Evolução.
FERRAMENTA	**PQQ — Escada dos Porquês** (sugerida para a 2ª área, o Mental Emocional Espiritual).
POR QUE ESTA	Para entender o que "ter mais energia" representa para ela e manter as mudanças ligadas a esse sentido.
O QUE FOI APRENDIDO	O "pra que" verdadeiro: "sentir que dou conta da minha rotina sem me abandonar".
CONDUTA / ACORDO	Lanche mantido; pausa de cinco minutos antes do almoço, sem tela.
ATÉ O PRÓXIMO ENCONTRO	Como a pausa antes do almoço muda a tarde.
HISTÓRICO	Com OQ³ ainda não aplicado, o Mapa do Propósito fica para depois, se fizer sentido.

5 Revisar o primeiro ciclo

RETORNO · CHECKPOINT

ENTRADA	Consulta marcada como "Reavaliação HOLOSCAN" na Agenda, por decisão da nutricionista.
O QUE ELA RELATA	A tarde mudou; a noite melhorou em parte. A culpa depois de comer ainda aparece.
O QUE A NUTRICIONISTA ORGANIZA	Revê o ponto de partida, as áreas iniciais, as ferramentas e os acordos. Decide reaplicar o HOLOSCAN porque a rotina mudou desde a primeira aplicação.
PARTE DO SISTEMA	HOLOSCAN (segunda aplicação, mesma versão do pacote), Evolução lado a lado, nova versão do Resultado HOLOS.
FERRAMENTA	Nenhuma nova: o encontro é de revisão.
POR QUE	A prioridade era olhar o caminho, não abrir outra frente.
O QUE FOI APRENDIDO	O Metabólico continua como 1ª área, com menos carga relatada nos sinais da tarde. A culpa depois de comer segue entre os sinais do Mental Emocional Espiritual.
CONDUTA / ACORDO	Lanche e pausa viram rotina; nova pergunta para o próximo ciclo: o que acontece quando ela "sai da linha".
ATÉ O PRÓXIMO ENCONTRO	Observar os dias em que ela sente que "perdeu tudo".
HISTÓRICO	Duas aplicações do HOLOSCAN na mesma versão, vistas lado a lado, sem cálculo de diferença.

6 Aprofundar uma nova camada

RETORNO

ENTRADA	Um fim de semana de festa: "Comi demais no sábado, então o domingo já estava perdido".
O QUE ELA RELATA	Quando "sai da linha", abandona tudo até segunda-feira.
O QUE A NUTRICIONISTA ORGANIZA	Há uma regra rígida operando. É hora de olhar para as ideias, não só para a rotina.
PARTE DO SISTEMA	Mapa de Crenças Alimentares.

FERRAMENTA	**Mapa de Crenças Alimentares**.
POR QUE ESTA	Ajuda a tornar visíveis as ideias que influenciam as escolhas e a observá-las em situações reais.
O QUE FOI APRENDIDO	Crença que mais atrapalha: "se eu errar uma refeição, o dia está perdido". De onde veio: dietas anteriores. Alternativa possível: "a próxima refeição é uma nova chance".
CONDUTA / ACORDO	Depois de um exagero, voltar ao combinado na refeição seguinte, sem compensar.
ATÉ O PRÓXIMO ENCONTRO	Perceber quando a frase antiga aparece.
HISTÓRICO	A camada nova aparece sem repetir a primeira consulta: o que já estava registrado continua valendo.

7 Consolidar

RETORNO · INTERVALO MAIOR

ENTRADA	Quatro semanas depois, por decisão combinada.
O QUE ELA RELATA	Conseguiu "voltar no dia seguinte" duas vezes. O trabalho anda pesado.
O QUE A NUTRICIONISTA ORGANIZA	Os acordos centrais se sustentam. O trabalho parece puxar outras áreas para baixo.
PARTE DO SISTEMA	Roda Holística da Vida, Conduta.
FERRAMENTA	**Roda Holística da Vida**.
POR QUE ESTA	Amplia o olhar quando diferentes áreas da vida ocupam energia e espaço.
O QUE FOI APRENDIDO	Área mais cuidada: relações. Menos cuidadas: lazer e saúde. A que puxa as outras para baixo: trabalho.
CONDUTA / ACORDO	Simplificar: um acordo só para a semana de fechamento do mês no trabalho.
ATÉ O PRÓXIMO ENCONTRO	O que mantém o lanche possível nas semanas pesadas.
HISTÓRICO	Acordos já sustentados saem do foco; ficam registrados como "Concluído".

8 Autonomia

RETORNO

ENTRADA	Marina chega com uma estratégia própria.
O QUE ELA RELATA	"Na semana do fechamento, preparei os lanches no domingo. Pedi ajuda ao meu companheiro com o jantar."
O QUE A NUTRICIONISTA ORGANIZA	Ela começa a antecipar as próprias situações difíceis. O apoio em casa apareceu como recurso.
PARTE DO SISTEMA	Conexão & Pertencimento.
FERRAMENTA	**Conexão & Pertencimento**.
POR QUE ESTA	Para planejar acordos que contem com o apoio real que ela tem.
O QUE FOI APRENDIDO	O companheiro apoia; a irmã apoia de longe; o ambiente de trabalho dificulta nos dias de pressão.
CONDUTA / ACORDO	Marina propõe o próprio acordo: dividir o jantar de quarta e sexta.
ATÉ O PRÓXIMO ENCONTRO	Como é ter ajuda sem sentir que "falhou".
HISTÓRICO	Pela primeira vez, um acordo nasce da paciente.

9 Reavaliação global

RETORNO · REAVALIAÇÃO HOLOSCAN

ENTRADA	Consulta marcada como "Reavaliação HOLOSCAN".
O QUE ELA RELATA	"Ainda belisco às vezes, mas não vira o dia inteiro."
O QUE A NUTRICIONISTA ORGANIZA	Compara o início com o momento atual: Mapeamentos, aplicações do HOLOSCAN, ferramentas, Condutas e acordos. Se uma aplicação tivesse sido feita em outra versão do pacote, os números não seriam comparados como equivalentes.
PARTE DO SISTEMA	HOLOSCAN (terceira aplicação), Evolução ("Linha de base × atual"), nova versão do Resultado HOLOS.
FERRAMENTA	Nenhuma nova.
POR QUE	O encontro é de leitura do caminho.
O QUE FOI APRENDIDO	Menos carga relatada nos sinais da tarde e da refeição; a culpa depois de comer aparece com menos frequência no relato dela. Nada disso é tratado como diagnóstico.
CONDUTA / ACORDO	Preparar o fechamento do ciclo no próximo encontro.
ATÉ O PRÓXIMO ENCONTRO	Marina pensa no que quer levar para a próxima fase.
HISTÓRICO	Três aplicações, lado a lado, na mesma versão do pacote.

10 Fechamento do ciclo e próxima fase

CONSULTA DE SÍNTESE

ENTRADA	A nutricionista prepara a síntese a partir do histórico.
O QUE ELA RELATA	"Eu entendi que meu problema não era falta de força de vontade, era o fim da tarde."
O QUE A NUTRICIONISTA ORGANIZA	De onde partiram, o que mudou, o que permanece, o que Marina já conduz sozinha.
PARTE DO SISTEMA	Conduta, Resultado HOLOS (observações), Relatório clínico, Carta ao Futuro Eu

	(opcional).
FERRAMENTA	**Carta ao Futuro Eu**, escrita por Marina para daqui a seis meses.
POR QUE ESTA	Para dar à próxima fase uma referência de direção que seja dela.
O QUE FOI APRENDIDO	Síntese: foco no fim da tarde, estratégias que cabem na rotina, apoio em casa, menos "tudo ou nada".
CONDUTA / ACORDO	Manutenção, com retorno em dois meses. Pontos a continuar observando: semanas de fechamento no trabalho e a frase "perdi tudo".
ATÉ O PRÓXIMO ENCONTRO	Marina segue sozinha os acordos que já são dela.
HISTÓRICO	Um ciclo completo, registrado do Mapeamento à síntese.

O QUE A PACIENTE PERCEBE

Ao final do ciclo, Marina não recebeu um "diagnóstico" nem uma lista de proibições. Recebeu, a cada etapa, o que foi entendido, o que foi combinado e o que observar. E aprendeu a ler os próprios padrões.

Visão resumida dos 10 atendimentos

O ciclo inteiro em duas tabelas: o que se faz em cada encontro e o que cada encontro deixa.

O que se faz

ATEND.	OBJETIVO	DADOS CONSULTADOS	RECURSO DO HOLOHACKING	POSSÍVEL FERRAMENTA
1	Compreender e priorizar	Mapeamento, conversa	Atendimento, HOLOSCAN, Próximos Passos, Conduta, Resultado HOLOS, Resultado Final	A principal sugerida pelo catálogo, se couber (ex.: Mapa da Rotina)
2	Aprofundar	Mapeamento de retorno, acordos, ferramenta anterior	Conduta anterior ao lado, Próximos Passos sem as já feitas	Complementar do catálogo (ex.: Gatilhos & Respostas)
3	Testar e observar	O que foi tentado, adesão, barreiras	Nova aplicação de ferramenta, revisão de acordos	Linha do Momentum, reaplicação quando fizer sentido
4	Integrar	Histórico até aqui	Evolução lado a lado	PQQ ou outra do território que a conversa pedir
5	Revisar o primeiro ciclo	Ponto de partida × agora	Reavaliação HOLOSCAN (se decidida), nova versão do Resultado	Nenhuma nova, em geral
6	Nova camada	O que permaneceu, 2ª prioridade	Próximos Passos, ferramentas	Mapa de Crenças Alimentares, Gatilhos & Respostas
7	Consolidar	Acordos sustentados e recorrências	Estados dos acordos, Conduta	Roda Holística da Vida, revisitar uma anterior
8	Autonomia	Estratégias da própria paciente	Conduta construída com a paciente	Conexão & Pertencimento
9	Reavaliação global	Início × momento atual	HOLOSCAN (se indicado), Evolução "Linha de base × atual"	Nenhuma nova, em geral
10	Fechamento e próxima fase	Todo o histórico	Conduta, observações do Resultado, Relatório clínico	Carta ao Futuro Eu, Mapa do Propósito (opcionais)

O que cada encontro deixa

ATEND.	DECISÃO PROFISSIONAL	RESULTADO PRODUZIDO	O QUE A PACIENTE LEVA	PRÓXIMO PASSO
1	Primeiro foco e primeiro acordo	HOLOSCAN, Conduta, Resultado HOLOS	PDF com o foco e o combinado	Observar até o retorno
2	Manter o eixo, complementar ou mudar de área	Nova ferramenta, Conduta revista	Clareza sobre o padrão	Testar o acordo novo
3	Calibrar a exigência	Acordos ajustados ao possível	"Não deu certo" também é informação	Sustentar o essencial

ATEND.	DECISÃO PROFISSIONAL	RESULTADO PRODUZIDO	O QUE A PACIENTE LEVA	PRÓXIMO PASSO
4	Conectar os achados	Leitura integrada registrada	Entendimento do próprio caminho	Preparar a revisão
5	Reaplicar ou não o HOLOSCAN; novo foco	Checkpoint do ciclo	O que mudou, o que fica	Abrir nova camada
6	Qual camada aprofundar	Nova ferramenta, novos acordos	Um padrão novo nomeado	Observar em situações reais
7	O que sai do foco	Acordos concluídos ou simplificados	Rotina mais estável	Espaçar consultas, se fizer sentido
8	Dar espaço à autonomia	Acordo proposto pela paciente	Confiança nas próprias estratégias	Reavaliar o percurso
9	Como ler o início × agora	Comparação descritiva, lado a lado	Visão do caminho percorrido	Fechar o ciclo
10	Novo ciclo, manutenção, intervalo ou encaminhamento	Síntese do ciclo e plano	Síntese, conquistas e o que continuar	Próxima fase

Corpo, Mente e Espírito ao longo da jornada

Três territórios, não três trilhos. A mesma paciente transita entre eles conforme o momento pede.

Corpo

Muitas vezes o ponto de partida: rotina, horários, fome, energia. É onde as mudanças precisam caber.

Mente

Aparece quando o "porquê" e os padrões pedem atenção: crenças, gatilhos, sentido da mudança.

Espírito

Ganha espaço quando direção, valores, apoio e pertencimento sustentam (ou dificultam) o caminho.

No caso de Marina, a jornada começou pelo **Corpo** (Mapa da Rotina), passou pela **Mente** (Gatilhos & Respostas, PQQ, Crenças), voltou ao **Corpo** quando a vida apertou (Linha do Momentum), abriu o **Espírito** (Roda, Conexão, Carta) e voltou à rotina na manutenção.

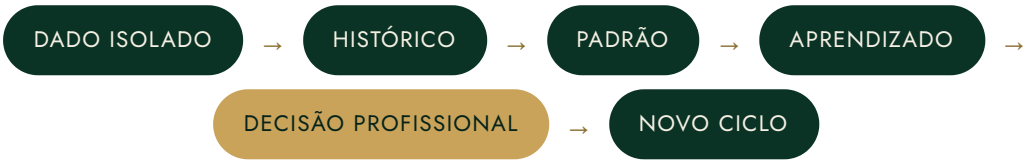
◆ ATENÇÃO METODOLÓGICA

Não existe alternância obrigatória Corpo → Mente → Espírito. O acompanhamento é adaptativo: segue o que a paciente mostra, não um roteiro.

Acompanhamento longitudinal

A força do HoloHacking aparece com o tempo: cada encontro acrescenta uma camada ao histórico.

A cada encontro, o HoloHacking acumula: o atendimento; os relatos (Mapeamentos); as aplicações do HOLOSCAN; as ferramentas; a leitura profissional; a Conduta e os acordos, com os seus estados; os Resultados HOLOS e as emissões; os documentos; e a linha do tempo.



◆ ATENÇÃO METODOLÓGICA

O sistema guarda e mostra o histórico; **não infere causalidade**. Quem reconhece padrões e decide o que fazer com eles é a nutricionista, com a paciente.

O QUE O SISTEMA FAZ

- Nada salvo é recalculado em silêncio: aplicações, Resultados e emissões ficam como foram feitos, com a versão do pacote metodológico usada.
- Quando o método evolui (uma nova versão do pacote), as aplicações antigas continuam legíveis e não são misturadas com as novas como se fossem iguais.
- A Evolução compara lado a lado, sem calcular diferenças de nota.

Papéis

Quem faz o quê na jornada. Esses papéis não se invertem.

Paciente

relata, participa, experimenta, observa

Nutricionista

escuta, investiga, interpreta, decide, conduz

HOLOSCAN

organiza os relatos segundo o método

Ferramentas

aprofundam áreas específicas

HoloHacking

registra e organiza a jornada

Tecnologia

apoia

> *O algoritmo não decide tratamento. A tecnologia apoia; a nutricionista conduz.*

Limites e segurança

O que o HoloHacking não faz, e o que a nutricionista faz quando algo ultrapassa a nutrição.

◆ ATENÇÃO METODOLÓGICA

O HoloHacking: - não diagnostica; - não substitui avaliação clínica; - não substitui o julgamento profissional; - não faz psicoterapia; - não transforma associação em causalidade; - não usa linguagem espiritual como se fosse fisiologia comprovada; - não decide a Conduta sozinho; - não interpreta exames nem documentos anexados.

O QUE A NUTRICIONISTA DECIDE

Quando surge uma necessidade **fora da competência nutricional** (sofrimento emocional importante, sinais que pedem investigação médica, suspeita de transtorno alimentar), a nutricionista **encaminha** ao profissional adequado. O HoloHacking registra; não encaminha sozinho.

Linguagem segura

EM VEZ DE	PREFIRA
"Seu sistema metabólico está ruim."	"Este eixo reuniu mais relatos nesta aplicação."
"Você tem fungos / está inflamada / tem toxinas."	"Esses relatos merecem ser aprofundados na conversa."
"Seu corpo está dizendo que..."	"O que você relatou mostra que vale olharmos para..."
"Esse é o verdadeiro motivo."	"Esse padrão apareceu no seu relato."
"Gravidade", "risco"	"Prioridade de investigação nesta etapa."

Visão futura

Pontos em que este documento descreve uma experiência desejada que ainda não existe no produto. Estão separados para não serem confundidos com funções atuais.

EXPERIÊNCIA DESEJADA	COMO É HOJE
Ciclo de atendimentos no sistema (contagem, marcos, "ciclo atual")	Não existe. O ciclo é conduzido pela nutricionista e fica no histórico.
Síntese do Ciclo como documento próprio	Não existe. Usa-se a Conduta, as observações do Resultado HOLOS e um Relatório clínico.
Regra oficial de periodicidade do HOLOSCAN	Não existe. Reaplicar é decisão profissional (Agenda tem o tipo "Reavaliação HOLOSCAN").
Comparação metodológica entre aplicações (diferenças de nota, Índice e Tríade)	Não existe. A Evolução mostra lado a lado, sem delta; a regra de comparabilidade não foi homologada.
Acompanhamento entre consultas pela paciente (registrar acordos, lembretes)	Não existe. A paciente recebe o PDF; o registro entre consultas acontece no Mapeamento de retorno.
Envio do Resultado por link	Não existe. O Resultado vai em PDF (WhatsApp no celular com anexo; no computador, a nutricionista anexa).
HOLOS AI integrada	Parcial. Hoje monta e copia o contexto do caso; a abertura direta em assistentes externos está "Em desenvolvimento".
Estados de consulta (confirmada, realizada, faltou)	Não existe. A Agenda tem consultas ativas, canceladas ou com atendimento registrado.
Sugestão automática de data de retorno	Foi retirada. O retorno é combinado e registrado na Conduta e na Agenda.
Texto aprovado "por que usamos" e "o que significa" para todas as ferramentas	Parcial. Hoje existe para algumas (Mapa da Rotina e PQQ, em "por que usamos").

Encerramento



O sistema organiza. O método orienta. A tecnologia sugere.
A nutricionista interpreta. A nutricionista decide.

HOLOHACKING · NUTRIÇÃO HOLÍSTICA

Este é o primeiro modelo do guia **Jornada da Nutricionista com a Paciente**. Ele foi escrito para ser completo; as próximas versões vão condensar, ajustar o tom e incorporar o que a prática mostrar.

Espaço reservado para a assinatura do método, créditos e contato institucional (a definir).

Documento baseado no HoloHacking em outubro de 2026, pacote metodológico HOLOS-V1 v6 e catálogo de Próximos Passos PP-V1. Todas as pessoas, telas e dados de exemplo são fictícios.